

REGIONE DEL VENETO
116117
MANUALE
-PROTOCOLLO 2-

GRUPPO TECNICO DI LAVORO

Adriano Valerio	Direttore CO SUEM 118 AOUIVR
Andrea Favaro	Direttore Dipartimento Emergenza e Area Critica AULSS 7 Coordinatore Co.Re. Triage
Marta Zanovello	UOC Governo Clinico Azienda Zero
Elena Vecchiato	Dirigente Medico DEA AULSS 7
Thomas Matteazzi	Dirigente Medico DEA AULSS 7
Denis Granzotto	Coordinatore DEA AULSS 2
Andrea Favaretto	Coordinatore CO SUEM 118 AOPD
Marco Manzini	Coordinatore CO SUEM 118 AOUIVR

PREMESSA

Il Ministero della Salute nel 2016 ha emanato le ‘Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del Numero Europeo Armonizzato a valenza sociale 116117’ esplicitando che, il suddetto numero non costituisce una mera sostituzione dei numeri dell’attuale servizio di Continuità assistenziale (CA) ma rappresenta un’opportunità per il miglioramento dell’assistenza sanitaria che può essere inserita nel contesto della rimodulazione delle attività delle cure primarie che le regioni stanno avviando o si accingono a riorganizzare, per gli aspetti di loro competenza. Il numero 116117, numero unico nazionale per l’accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità e la sua attivazione ha l’obiettivo di mettere in contatto l’utente con un operatore competente oppure con un medico per assicurare assistenza o consulenza sanitaria, in questo modo i cittadini dovranno ricordare un solo numero per poter ricevere risposta relativamente a problemi differenti di salute.

(1)

Con il decreto n. 32 del 4 aprile 2023 e successivo n. 86 del 19/6/23 il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha istituito un gruppo di lavoro regionale (CO 116-117) per lo sviluppo operativo del modello della Centrale Operativa 116117.

Obiettivi primari che si è posto il gruppo di lavoro sono: rendere facilmente fruibile ai cittadini una risposta basata su livelli di cura appropriati, identificare dei percorsi che permettano di ridurre l’overcrowding dei servizi di emergenza ed urgenza (SUEM-118 e DEA-Pronto Soccorso). Il gruppo tecnico ha effettuato un’indagine su flusso EMUR PS (2022) che attraverso il calcolo di indicatori NO CORE D05C, D06C, D07Ca, D07Cb del sistema di garanzia, ha evidenziato un possibile bacino di utenza al numero armonizzato pari a circa il 30% degli accessi ai servizi di emergenza (SUEM-118 e DEA-Pronto Soccorso)

Coordinato dal gruppo di lavoro 116-117 è stato composto un gruppo tecnico formato da medici e infermieri del SUEM-118 e del Coordinamento Regionale Triage formatori del DiRe e Triage Ospedaliero. È stata fatta una revisione della letteratura disponibile sui sistemi analoghi in uso in diverse realtà nazionali ed internazionali.

Al fine di rendere il processo di risposta 116-117 omogeneo, integrato e sinergico con i sistemi DiRe del SUEM 118 e CoRe del Triage ospedaliero già in uso in Regione Veneto, si è deciso di partire dall’analisi delle schede dei due sistemi per estrapolare le categorie di bisogni sanitari per cui

l'utente potrebbe interrogare l'operatore del 116-117 e per ciascuno definito il processo operativo decisionale.

RISPOSTA OPERATIVA 116-117

Alla chiamata dell'utente, l'operatore tecnico della centrale 116-117 procede con le seguenti fasi.

FASE 1 - Identificazione del chiamante

Dati anagrafici

Chi chiama (tabella I)

Dati per la reperibilità

Tabella I: classificazione dei chiamanti

Denominazione	Definizione
Paziente	chi chiama per sè stesso
Caregiver/familiare/assistente	chi chiama per un assistito prossimo (lo vede)
Altro	chi chiama per un soggetto che necessita di assistenza ma non ha legami assistenziali continuativi (es: vicino di casa)

FASE 2 - Esclusione di un problema emergente

L'operatore procede alla esclusione di alterazioni del livello di coscienza (Airway), respiro (Breathing) e C (Circulation) che identificano criteri di attivazione del SUEM-118, la loro identificazione comporta il trasferimento della chiamata.

FASE 3. Definizione del problema di salute motivo della chiamata

L'operatore classifica il/i problemi di salute riferiti con la ricerca gerarchica attraverso schede e parole TAG.

Una volta identificato il problema principale della chiamata, l'operatore procede con l'applicazione della flow chart relativa.

Ogni scheda prevede la descrizione dei criteri di accesso alla scheda e l'elenco delle parole di "entrata" (TAG), sinonimi, talvolta anche popolari, del sintomo /problema stesso.

FASE 3. Definizione del percorso

L'operatore procede, sulla base del protocollo descritto sulle schede, ad attivare la risposta prevista.

SCHEDA LOC A-B-C

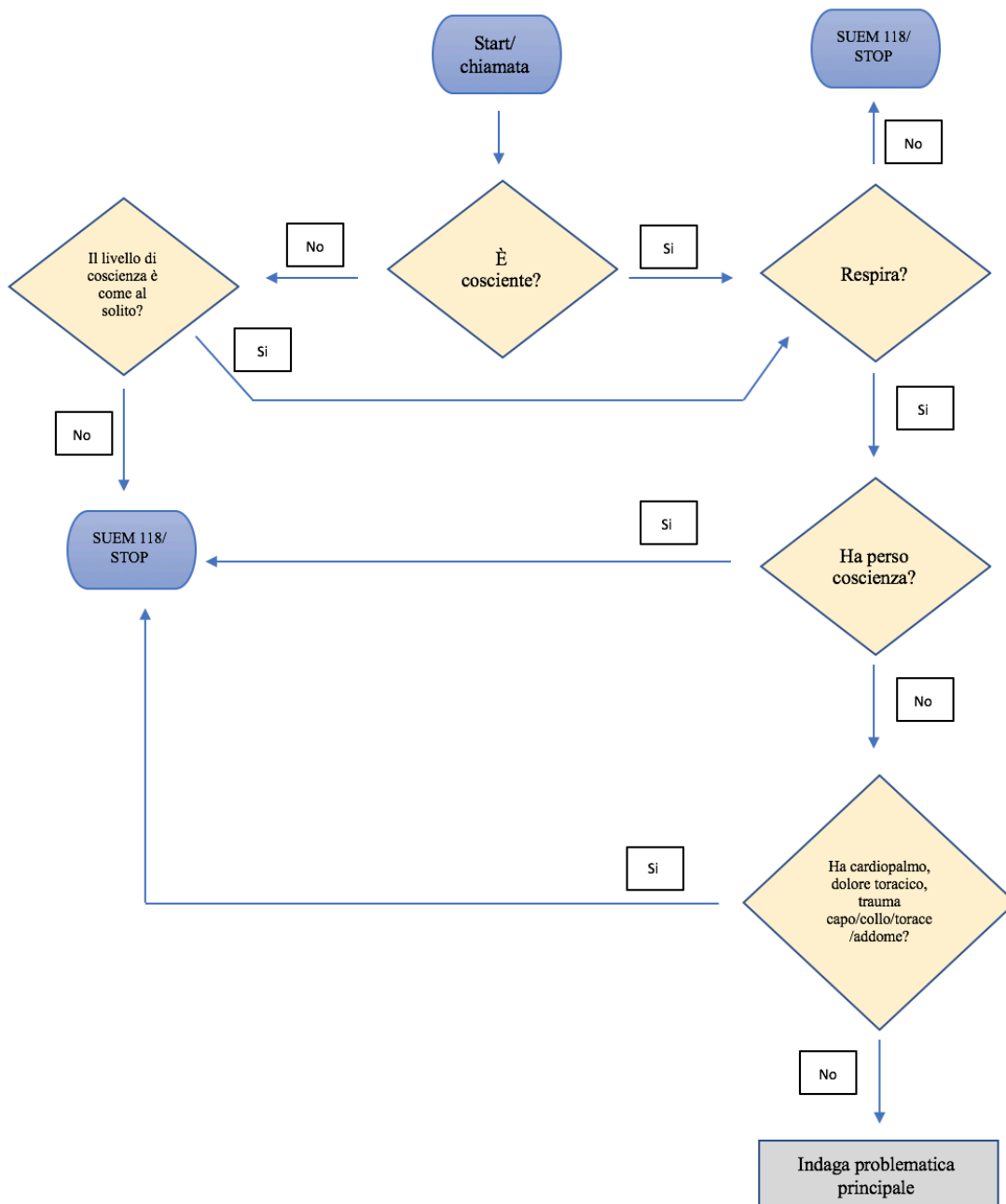


Figura 1: flow chart di indagine delle problematiche legate a livello di coscienza, A, B e C.

Se l'operatore rileverà l'assenza di segni suggestivi di problematica emergente procederà con l'indagine della problematica per cui avviene il contatto con la centrale 116117 come riportato in figura 2.

FLOWCHART PERCORSO DI CHIAMATA

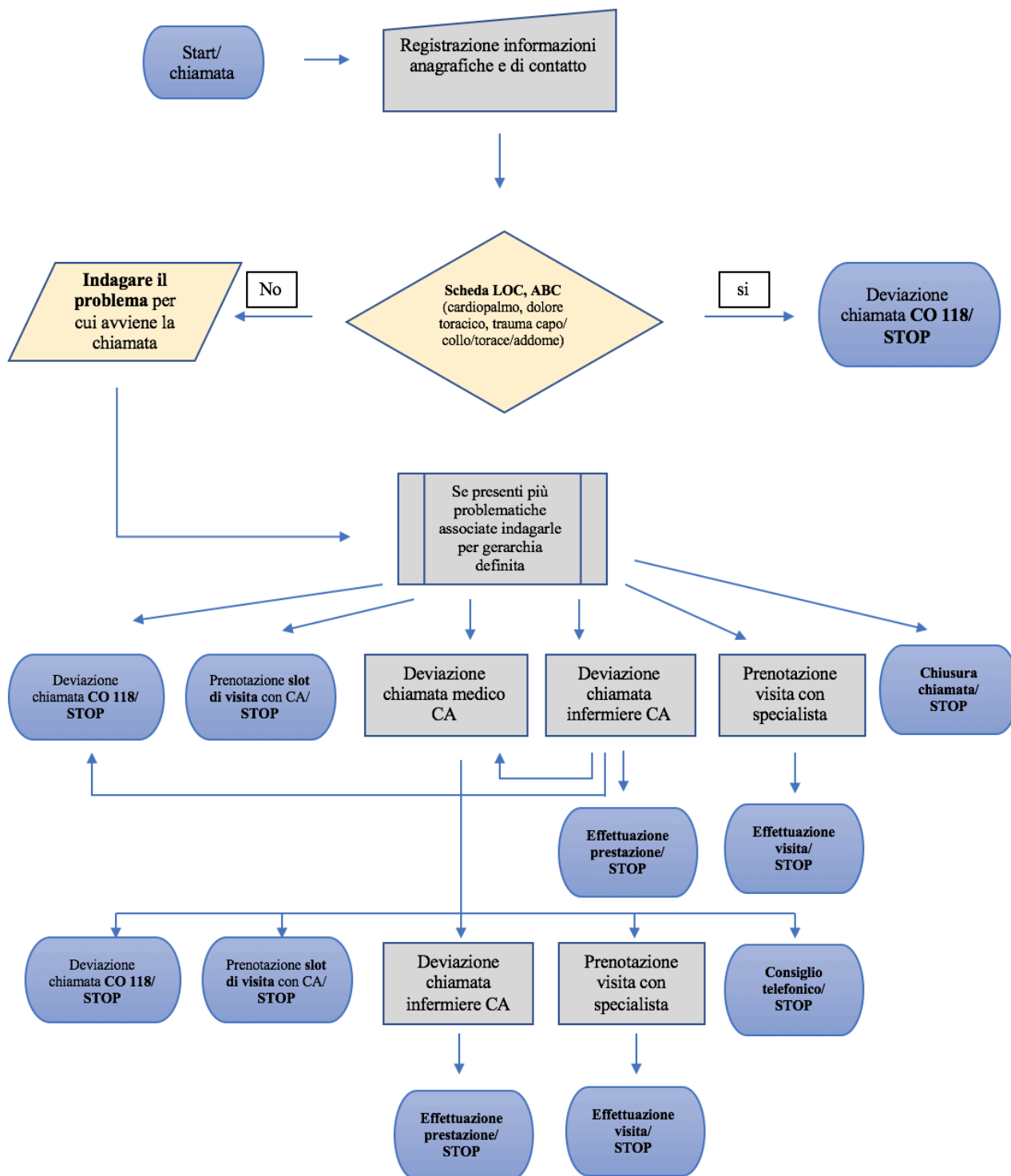


Figura 2: Flow Chart del percorso di chiamata.

Sulla base delle schede fornite, da utilizzare secondo gerarchia, l'operatore tecnico sarà in grado di (Figura 2):

- Deviare la chiamata al SUEM 118 se il paziente riferisce la presenza di sintomi codificati come 'parole alert' nel manuale,

- Deviare la chiamata ai medici di CA disponibili per la ricezione;
- Prenotare una visita presso gli ambulatori della CA (prenotazione SLOT di visita): gli SLOT saranno proposti in base alla disponibilità nel territorio di residenza del soggetto;
- Deviare la chiamata all'infermiere di centrale operativa: in base alle procedure attribuite al personale infermieristico; l'infermiere di centrale potrà poi procedere con le medesime modalità di deviazione o risoluzione della chiamata;
- Consultare il medico di centrale per situazioni non risolubili o complesse
- Deviare la chiamata alla Centrale ADI se il paziente è in carico;
- Prenotare una visita con un medico specialista per i casi previsti per telemedicina: prenotazione di una visita online con specialista disponibile sul territorio regionale.

Il medico di CA che prende in carico la chiamata potrà:

- risolverla con consiglio
- rinviare al MMG o PLS per programmazione di visita
- fissando un appuntamento di visita presso gli ambulatori di CA (prenotazione SLOT di visita)
- inviare il soggetto in PS
- consultare online il medico di PS per il case management di situazioni particolari secondo specifiche procedure
- attivare COT

La gerarchia da utilizzare per la selezione delle 'schede problema' è la seguente:

- Scheda LOC, ABC
- Febbre
- Dolore addominale
- Disturbi neurologici
- Vertigini
- Cefalea
- Dolore collo schiena
- Disturbi psichici
- Intossicazione
- Dermatologico
- Emorragie non traumatiche
- Astenia
- Odontalgia
- Dolore arti
- Problemi ostetrico/ginecologico
- Oculistico
- Orecchio
- Bocca
- Urologico
- Trauma minore
- Pressione alta/bassa
- Dolore non riconducibile ad altra scheda specifica
- Corpo estraneo
- Vomito/diarrea
- Problematica non altrimenti classificabile in altra scheda
- Procedure

L'operatore dovrà chiudere la chiamata seguendo le indicazioni date dalla relativa flow chart (Figura 2) con i seguenti esiti:

- deviazione della chiamata al 118
- deviazione della chiamata all'infermiere
- deviazione della chiamata al medico di continuità assistenziale
- deviazione alla centrale ADI
- prenotazione di uno slot di visita
- prenotazione di un teleconsulto con specialista
- chiusura diretta (chiamata non pertinente)

Il consulto telefonico con il medico di continuità assistenziale (Figura 2) potrà esitare in:

- chiusura della cartella con consiglio telefonico,
- chiusura della cartella con invio al MMG o PLS
- chiusura della cartella con invio in PS con mezzi propri,
- chiusura della cartella come non pertinente,
- chiusura della cartella con deviazione al 118,
- chiusura della cartella dopo consulto con specialista e dopo aver richiamato il paziente,
- attivazione di un teleconsulto con specialista (ginecologo, CAV, pediatra, PS online),
- deviazione della chiamata all'infermiere di centrale,
- deviazione della chiamata all'operatore per prenotazione di slot di visita.

Di seguito vengono riportate le schede problema.

Le problematiche verranno descritte in tabelle in cui sono riportati:

- titolo scheda: denominazione della scheda,
- definizione: rappresenta la chiave di ingresso alla scheda e definisce quale deve essere la problematica presentata,
- parole di entrata: raggruppa tutte le parole che esprimono la problematica specifica,
- parole alert: raggruppamento di tutte le parole che, se dichiarate in associazione alla problematica specifica, devono far attivare la deviazione di chiamata al SUEM 118
- flow chart: percorso grafico di sviluppo della problematica specifica

Problematiche della scheda LOC, ABC

Titolo scheda	Sincope
Definizione	Perdita di coscienza di breve durata (a rapida risoluzione)
Parole di entrata	Non rispondeva più, non dava segni di vita, ha perso coscienza, ha perso i sensi, è collassato, è svenuto, è sincopato,
Parole alert per 118	Tutte le parole di entrata
Flowchart	Vedi figura 1

Titolo scheda	Dispnea
Definizione	Mancanza di respiro riferita
Parole di entrata	Mancanza di respiro, affanno, respiro corto, mancanza di fiato, mancanza di aria, fame d'aria
Parole alert per 118	Tutte le parole di entrata
Flowchart	Vedi figura 1

Titolo scheda	Cardiopalmò
Definizione	Riferito battito cardiaco alterato
Parole di entrata	Battito cardiaco accelerato, cuore che batte veloce, tachicardia, pulsazioni rapide, aumento della frequenza cardiaca, cuore in iperattività, battarella, cuore che salta un battito, cuore che si ferma, sentire il cuore nelle orecchie, bradicardia, cuore che salta in gola.
Parole alert per 118	Tutte le parole di entrata
Flowchart	Vedi figura 1

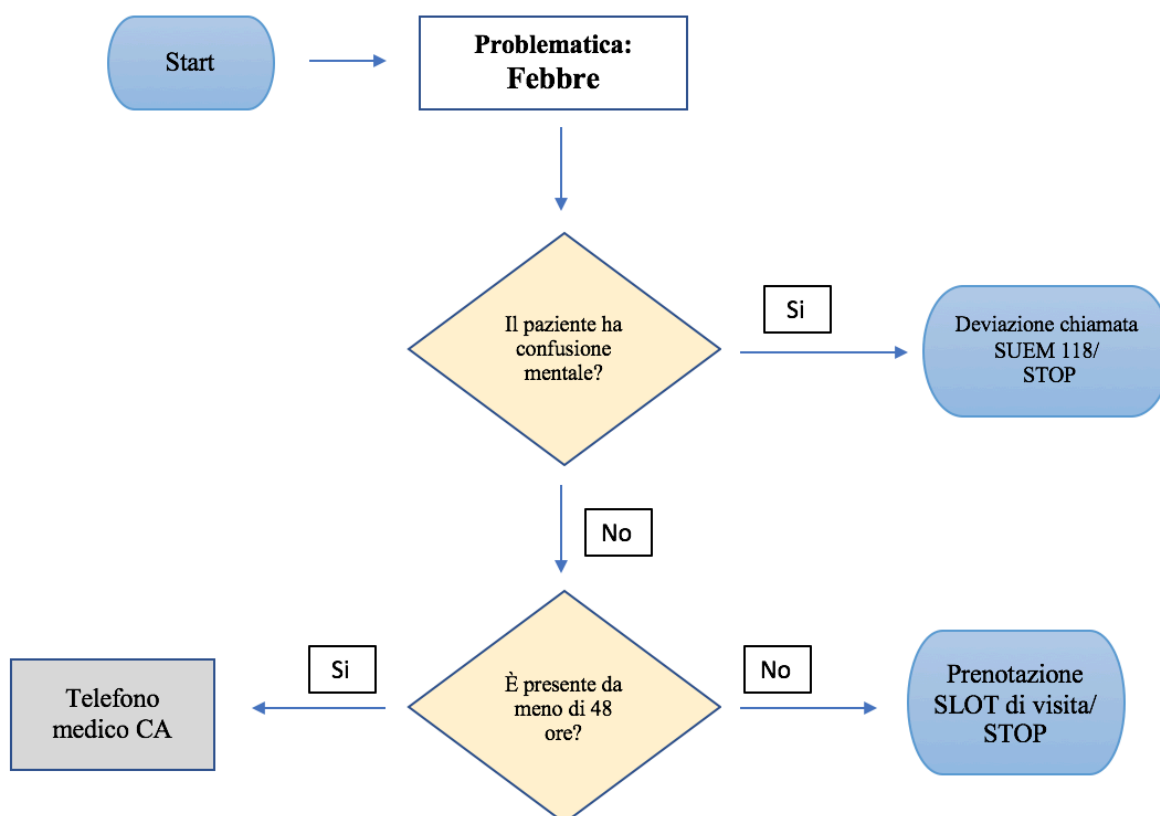
Titolo scheda	Dolore toracico
Definizione	Dolore al torace di origine non traumatica
Parole di entrata	Mal di stomaco, male al torace,
Parole alert per 118	Tutte le parole di entrata
Flowchart	Vedi figura 1

Titolo scheda	Trauma capo/collo/torace/addome
Definizione	Traumatismi di qualsiasi natura a capo, collo, torace e addome
Parole di entrata	Ho sbattuto/mi sono ferito/ho un trauma/ho colpito il capo/collo/torace/addome
Parole alert per 118	Tutte le parole di entrata
Flowchart	Vedi figura 1

SCHEMA FEBBRE

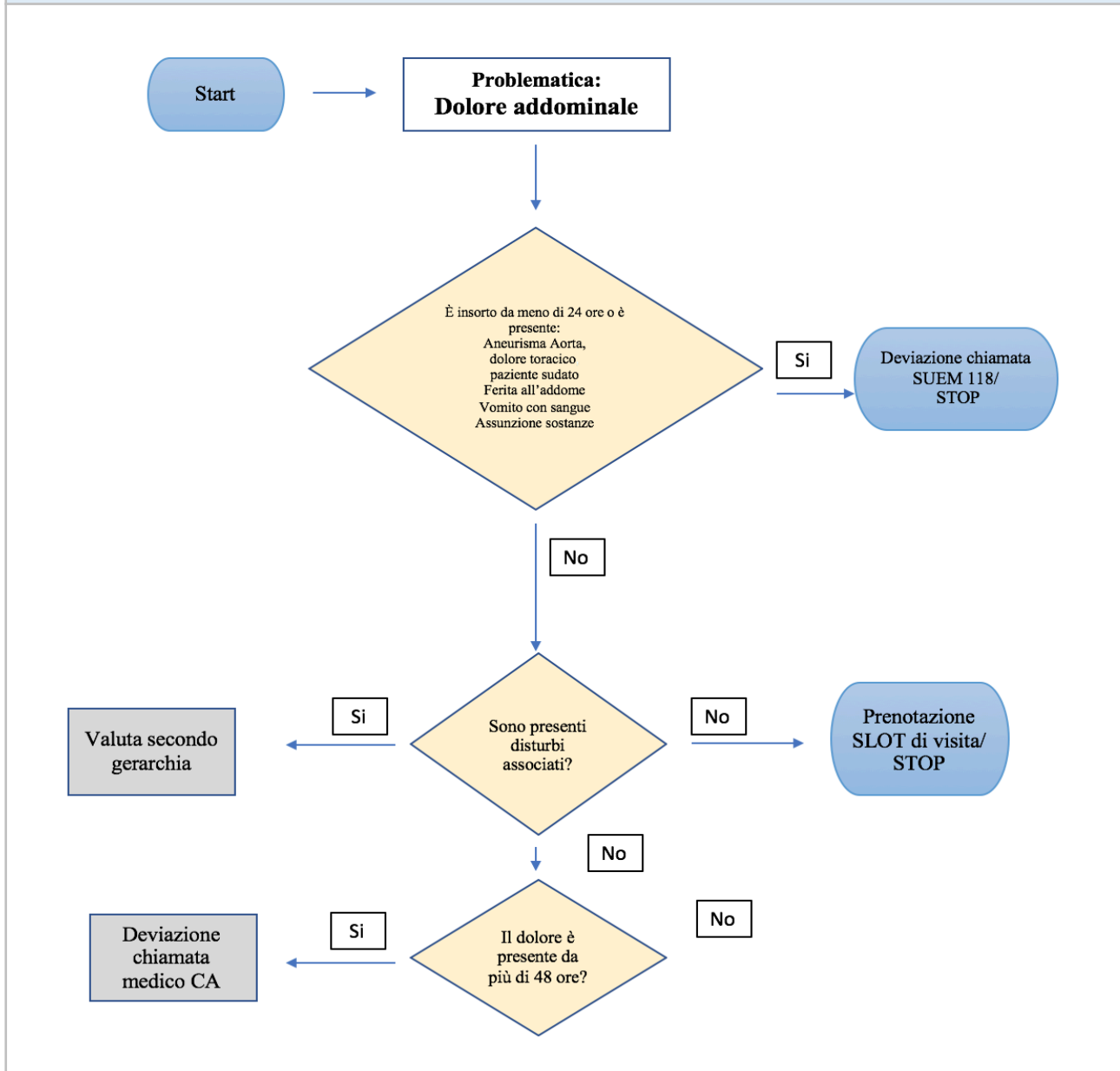
Titolo scheda	Febbre
Definizione	Temperatura Corporea $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$
Parole di entrata	Febbre, ipertermia, iperpiressia, brividi, 'è tanto caldo', ho i brividi a freddo, tremori, temperatura elevata
Parole alert per 118	Confusione mentale, sincope, dispnea, cardiopalmo

Flowchart



SCHEDA DOLORE ADDOMINALE

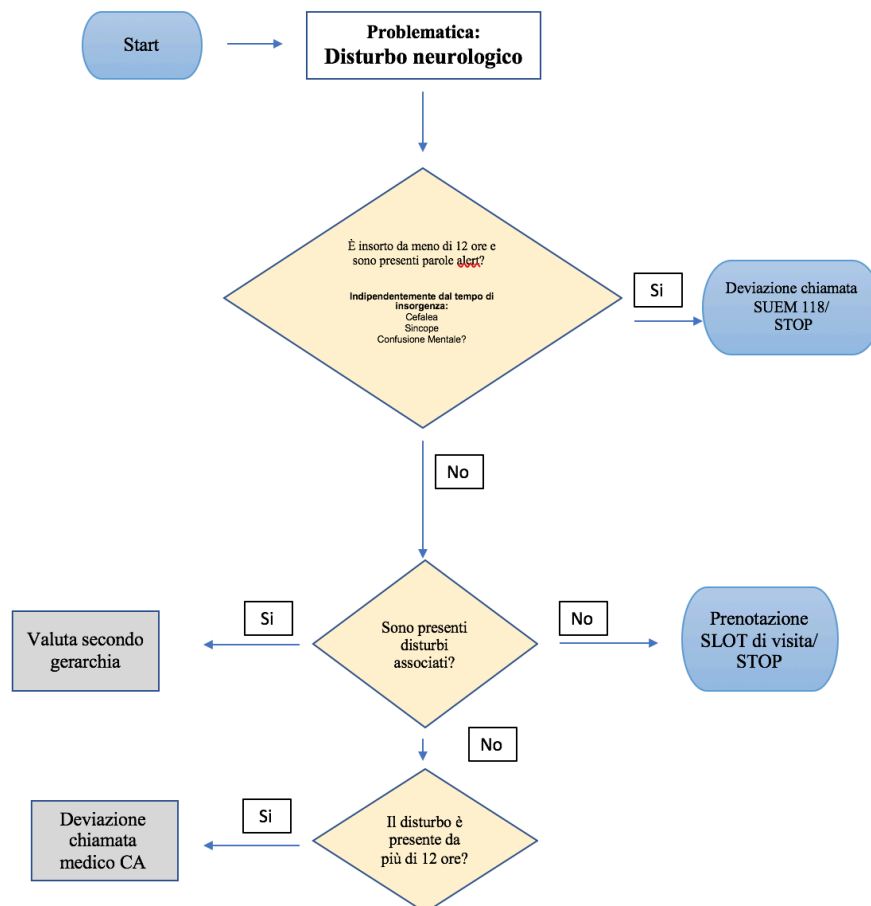
Titolo scheda	Dolore addominale
Definizione	Dolore all'addome di origine non traumatica
Parole di entrata	Dolore all'addome, dolore alla pancia, <u>mal di stomaco (tra lo sterno e l'ombelico)</u> , crampi addominali, <u>dolore gastrico</u> , dolore al ventre, fastidio alla pancia, dolore al fianco, dolore sopra al pube, dolore in basso, dolore attorno all'ombelico, pancia gonfia, indigestione, <u>bruciore allo stomaco</u>
Parole alert per 118	Aneurisma, aneurisma aorta, stomaco, dolore sopra ombelico (?), sudato, ferita, vomito con sangue, assunzione di sostanze
Flowchart	



DISTURBO NEUROLOGICO

Titolo scheda	Disturbo neurologico
Definizione	In assenza di traumi , alterazione della forza (perdita parziale o completa) o della sensibilità agli arti (dal formicolio sino all'insensibilità), alterazioni del campo visivo, della parola
Parole di entrata	Fa fatica a parlare, fa fatica a deglutire, perdita di forza ad un arto, sorride con metà bocca, metà faccia è immobile, non riesce a muovere gli arti, non alza un braccio, non muove una gamba, trascina una gamba, vede doppio, intorpidimento, formicolio, vede male (non vede una parte del campo visivo, vede un pezzo del campo visivo nero, vede una macchia nera), non riesce a chiudere un occhio, cammina male, non riesce a deglutire, non parla bene, parla male, disturbo dell'equilibrio, sbandamento
Parole alert per 118 (devono contenere il fattore tempo, eccezion fatta per l'associazione di disturbo neurologico con sincope, cefalea e disturbi psichici che sono indipendenti dal tempo)	Indipendentemente dal tempo di insorgenza: Sincope, cefalea, disturbi psichici. Se il disturbo è presente da meno di 24 ore

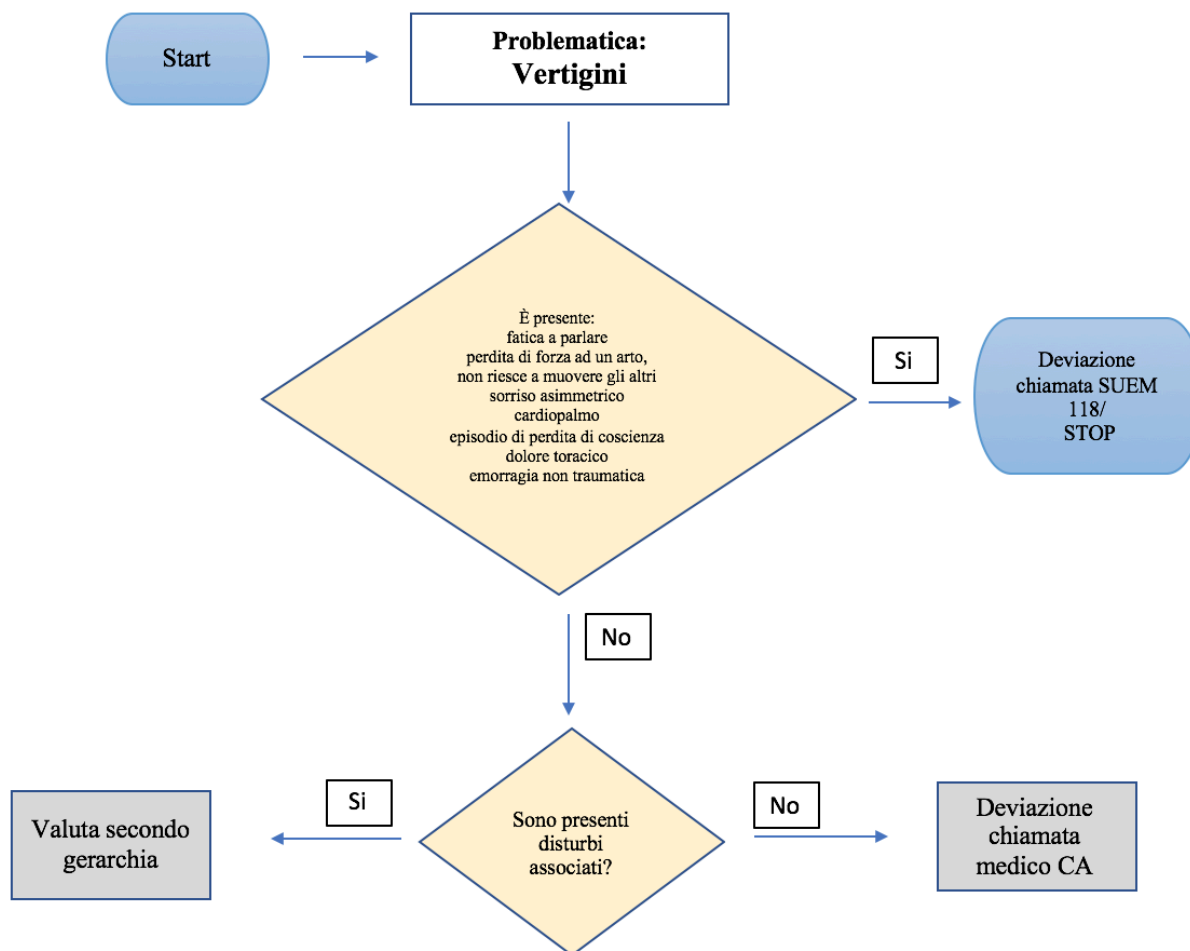
Flowchart



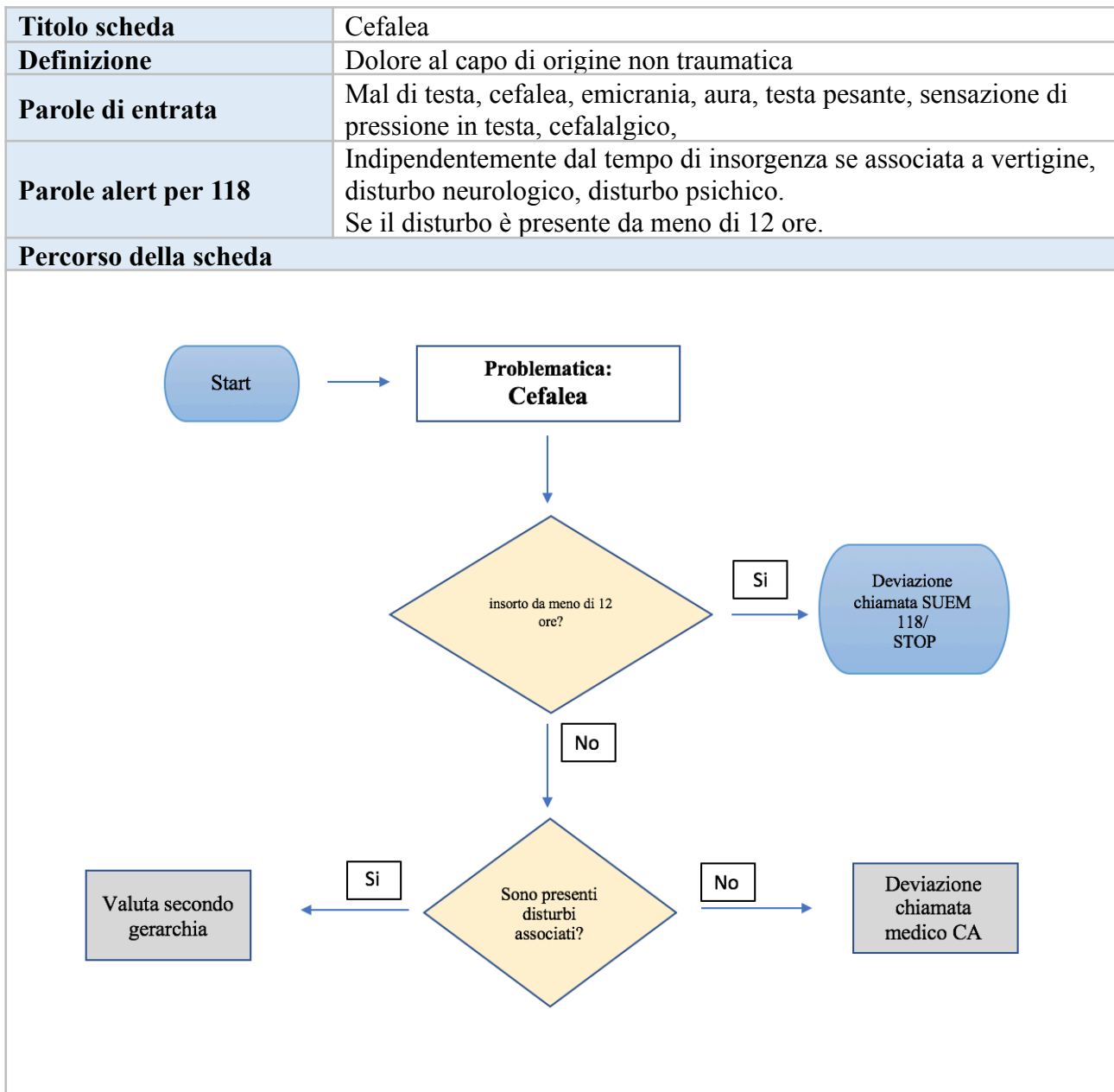
VERTIGINI

Titolo scheda	Vertigini
Definizione	Sensazione soggettiva di movimento rotatorio, oscillatorio pur rimanendo fermi
Parole di entrata	Vertigini, capogiro, il mondo gira, continuo a girare, gira tutto, vedo tutto girare, la stanza gira, mi sento girare, se mi muovo gira tutto,
Parole alert per 118	Indipendentemente dal tempo di insorgenza se associata a cefalea. Se non riesce a camminare e stare in piedi Se il disturbo è presente da meno di 12 ore.

Flowchart



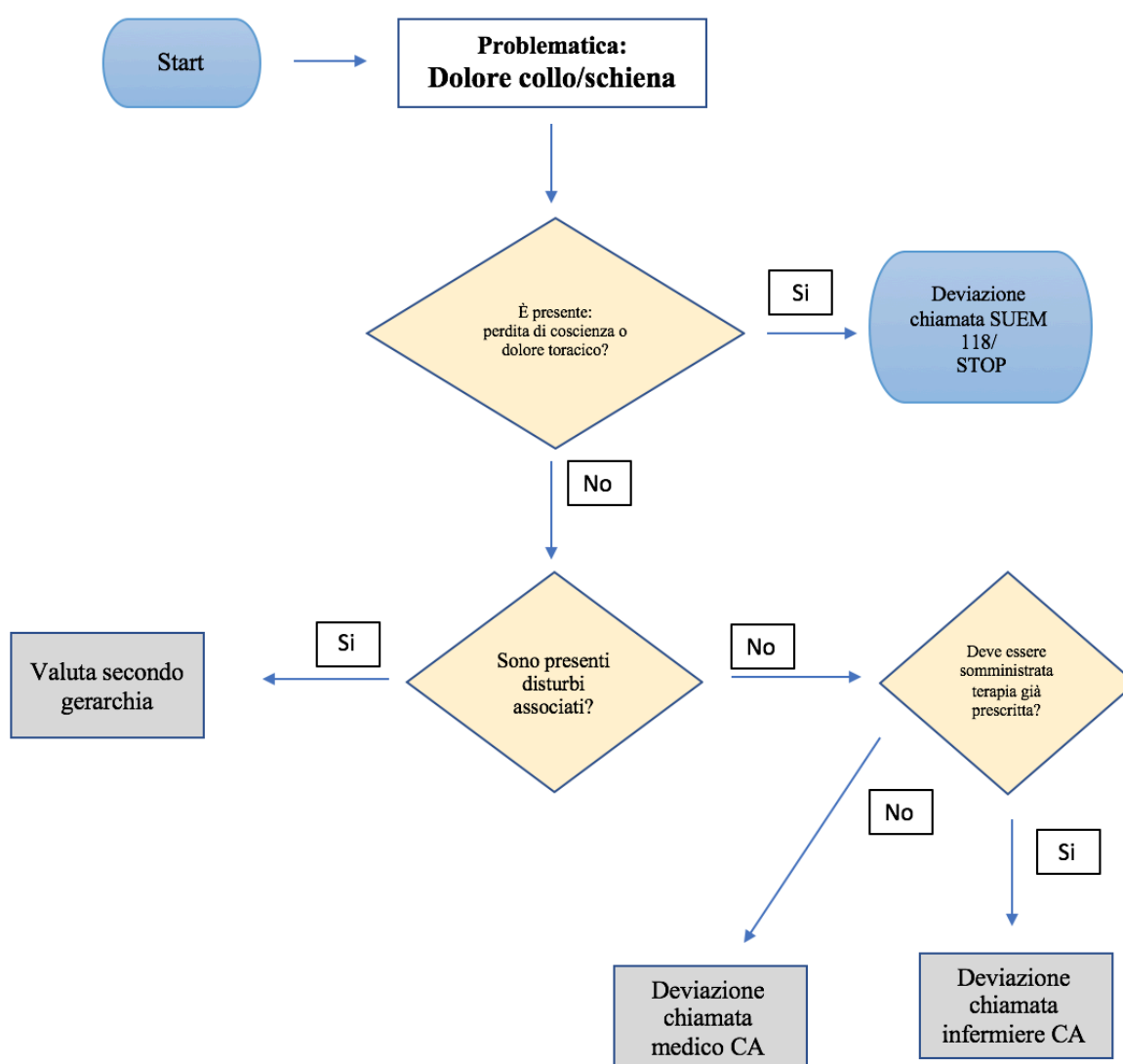
CEFALEA



DOLORE COLLO/SCHIENA

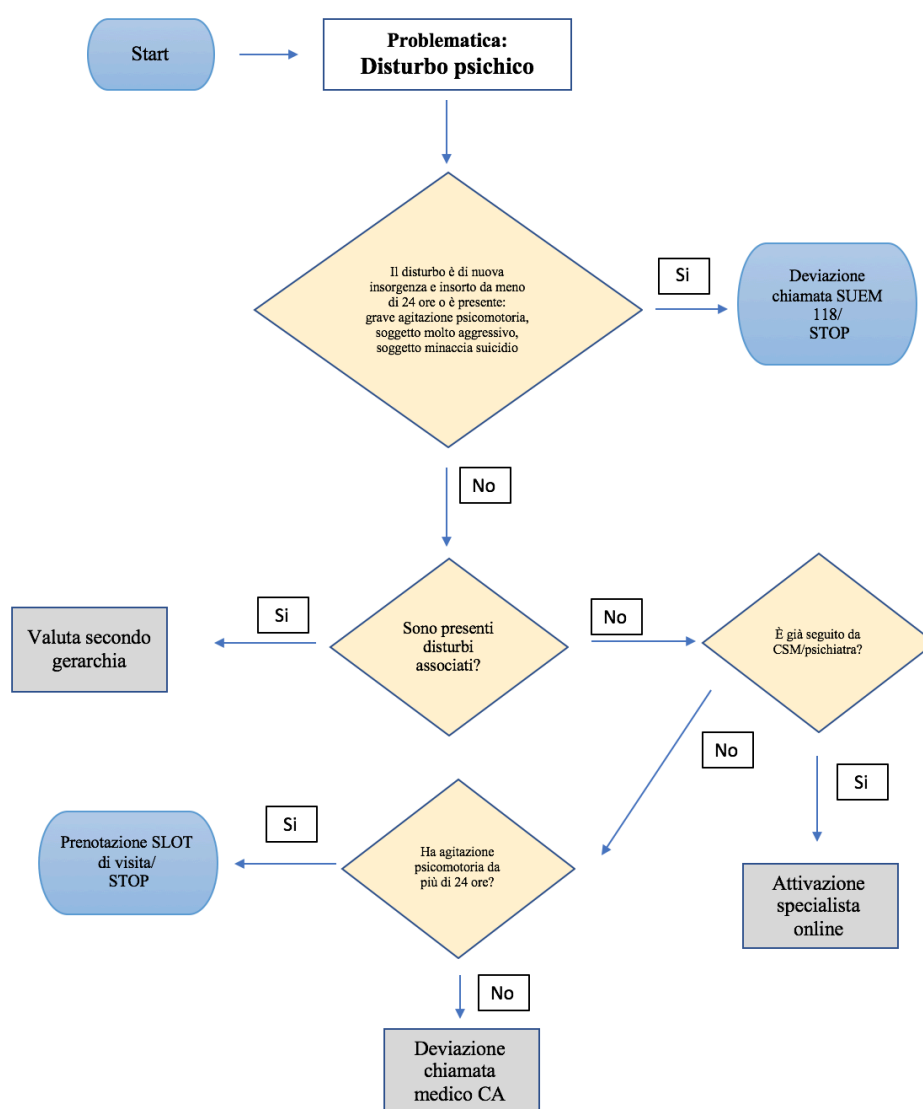
Titolo scheda	Dolore collo schiena
Definizione	Dolore, di origine non traumatica, localizzata alla regione posteriore del torace
Parole di entrata	Mal di schiena, schiena bloccata, colpo della strega, dolore ai lombi, contrattura alla schiena, sensazione di tensione alla schiena, dolore dorsale, dolore lombare, dolore cervicale, cervicali, dolore al collo, male al collo, dolore ai reni
Parole alert per 118	Se associata a perdita di coscienza, dolore toracico, noto aneurisma dell'aorta, perdita di sensibilità agli arti

Flowchart



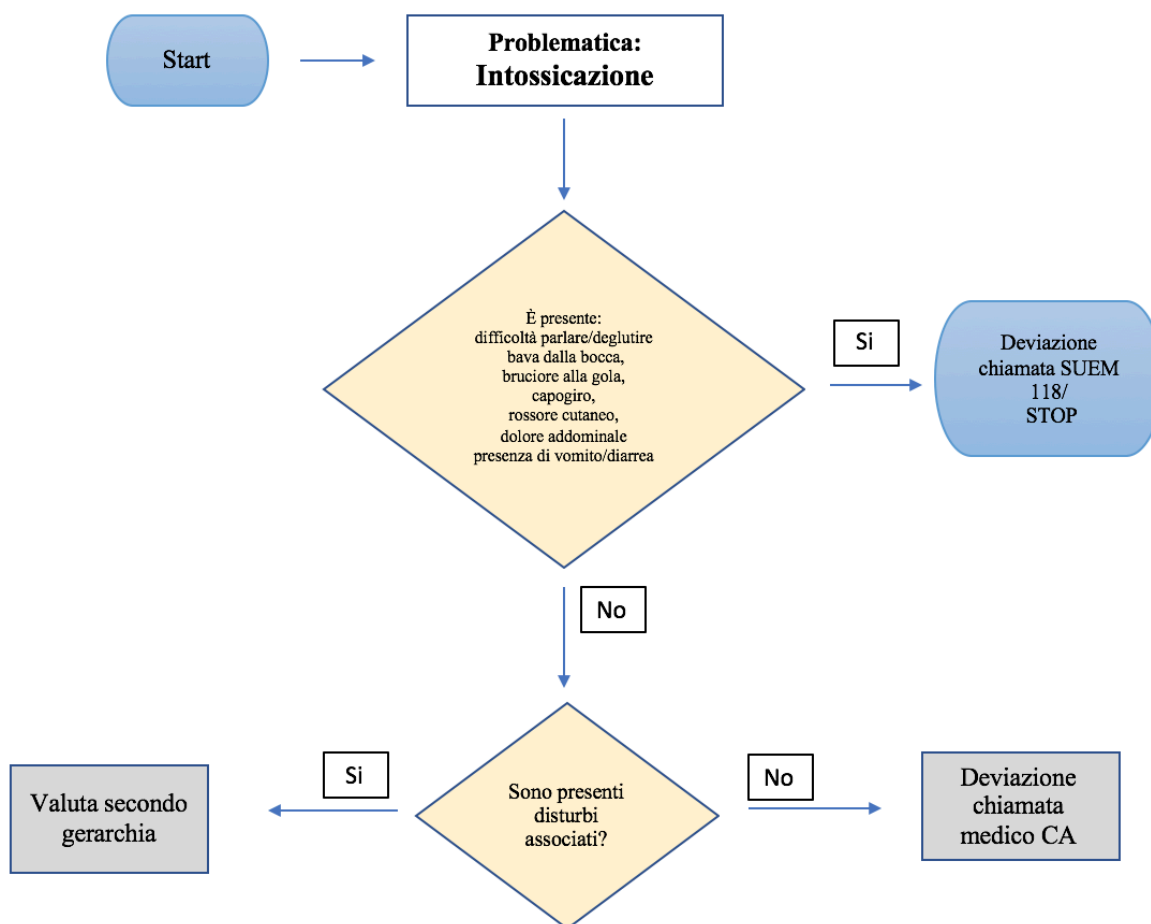
DISTURBO PSICHICO

Titolo scheda	Disturbo psichico
Definizione	Alterazione dello stato cognitivo (paziente confuso, agitato, allucinato, disorientato, aggressivo), paziente con problematica psichiatrica noto
Parole di entrata	Confusione mentale, soggetto agitato, soggetto allucinato, soggetto disorientato, soggetto aggressivo, soggetto psichiatrico, ansia, depressione, giù di morale, ho voglia di parlare, mi sento solo, sono triste, mi sento nervoso, rifiuta di alimentarsi,
Parole alert per 118	Indipendentemente dal tempo se associato a disturbo neurologico, cefalea, febbre, paziente in grave agitazione psicomotoria/aggressivo (anche nei confronti degli altri), minaccia di uccidersi, minaccia di uccidere qualcuno Se il disturbo è presente da meno di 24 ore.
Flowchart	



INTOSSICAZIONE

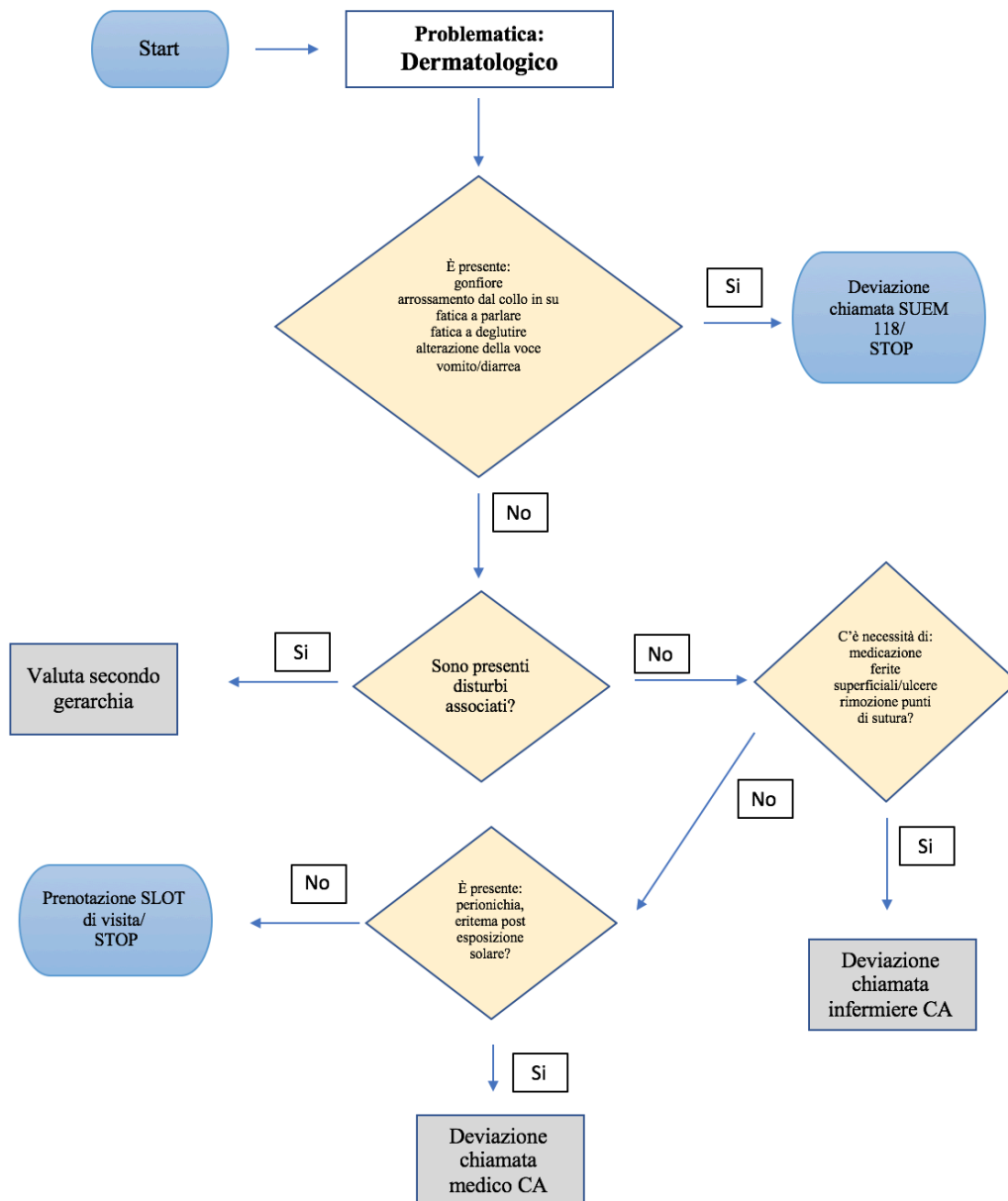
Titolo scheda	Intossicazione
Definizione	Assunzione, contatto o inalazione di sostanze potenzialmente dannose. Assunzione incongrua di farmaci.
Parole di entrata	Ho sbagliato ad assumere un farmaco che prendo abitualmente (es: più volte la pastiglia), contatto cutaneo con sostanza x, ho mangiato/bevuto/inalato/fumato una sostanza x (potenzialmente dannosa)
Parole alert per 118	Incosciente, difficoltà a parlare, a deglutire, a respirare, esce bava dalla bocca, bruciore alla gola, capogiro, rossore cutaneo, dolore addominale, presenza di vomito/diarrea
Percorso della scheda	



DERMATOLOGICO

Titolo scheda	Dermatologico
Definizione	Reazione cutanea comprese anche le reazioni dopo puntura di insetto o morso di animale
Parole di entrata	Eruzione cutanea, rossore, presenza di bollicine sulla pelle, pomfi, nuove lesioni sulla pelle, presenza di chiazze, prurito, presenza di macchie, segni di morso di animale, zecca, insetto, presenza di puntini, vescicole, presenza di croste, puntura da insetto/animali,
Parole alert per 118	Dispnea (fatica a respirare), fatica a parlare, fatica a deglutire, alterazione del suono della voce, gonfiore, arrossamento dal collo in su, capogiro, presenza di vomito/diarrea

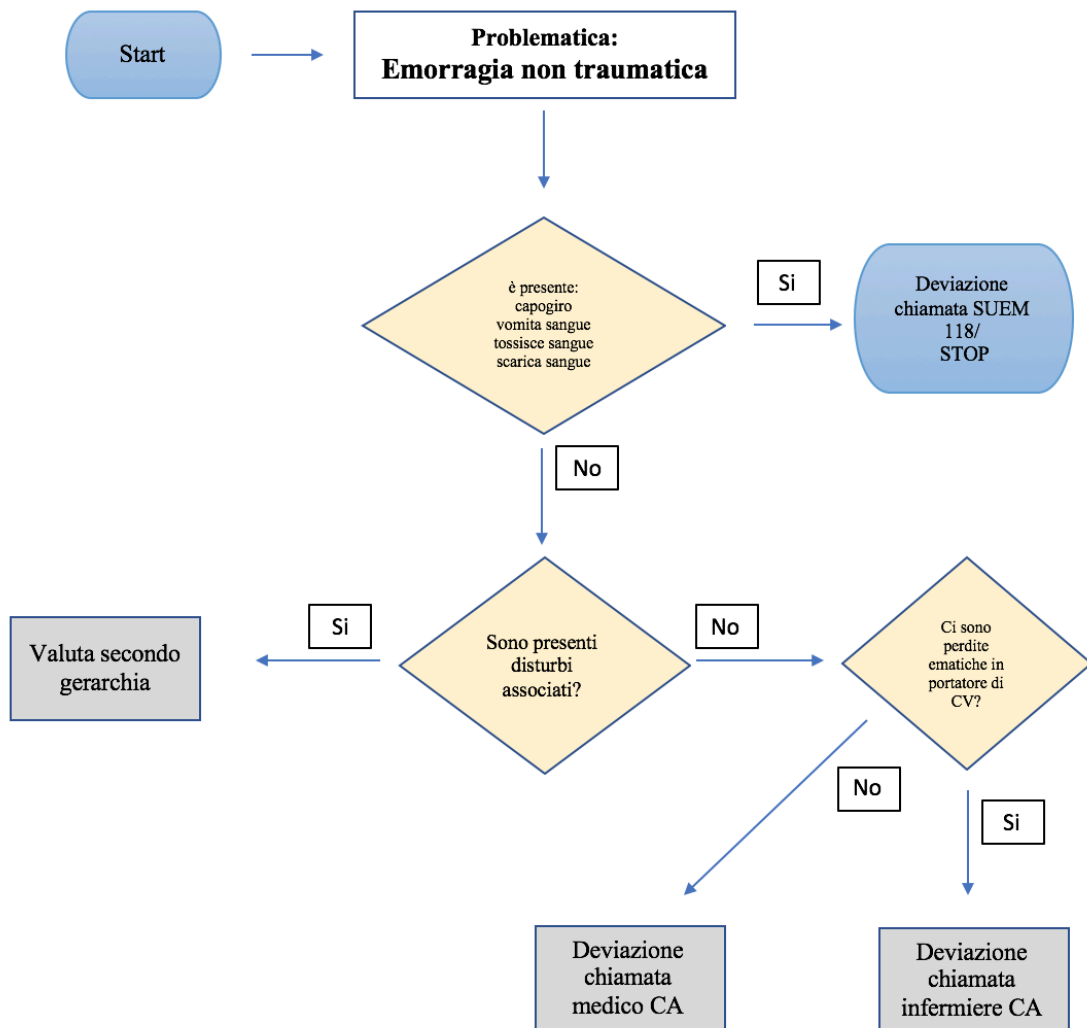
Flowchart



EMORRAGIA NON TRAUMATICA

Titolo scheda	Emorragie non traumatiche
Definizione	Perdita di sangue senza traumatismi associati
Parole di entrata	Perdita di sangue, emorragia, scarica sangue, vomita sangue, fa pipì rossa/con sangue, epistassi, perdita di sangue dal naso, feci striate di rosso, sangue nel water, ematuria, sangue sul fazzoletto, tosse/catarro con sangue, feci scure/nere, sangue dalle gengive, sangue dall'orecchio, sangue dalla bocca,
Parole alert per 118	Perdita di coscienza, difficoltà a respirare, capogiro, vomita sangue, tosse con sangue, scarica sangue, cacca nera

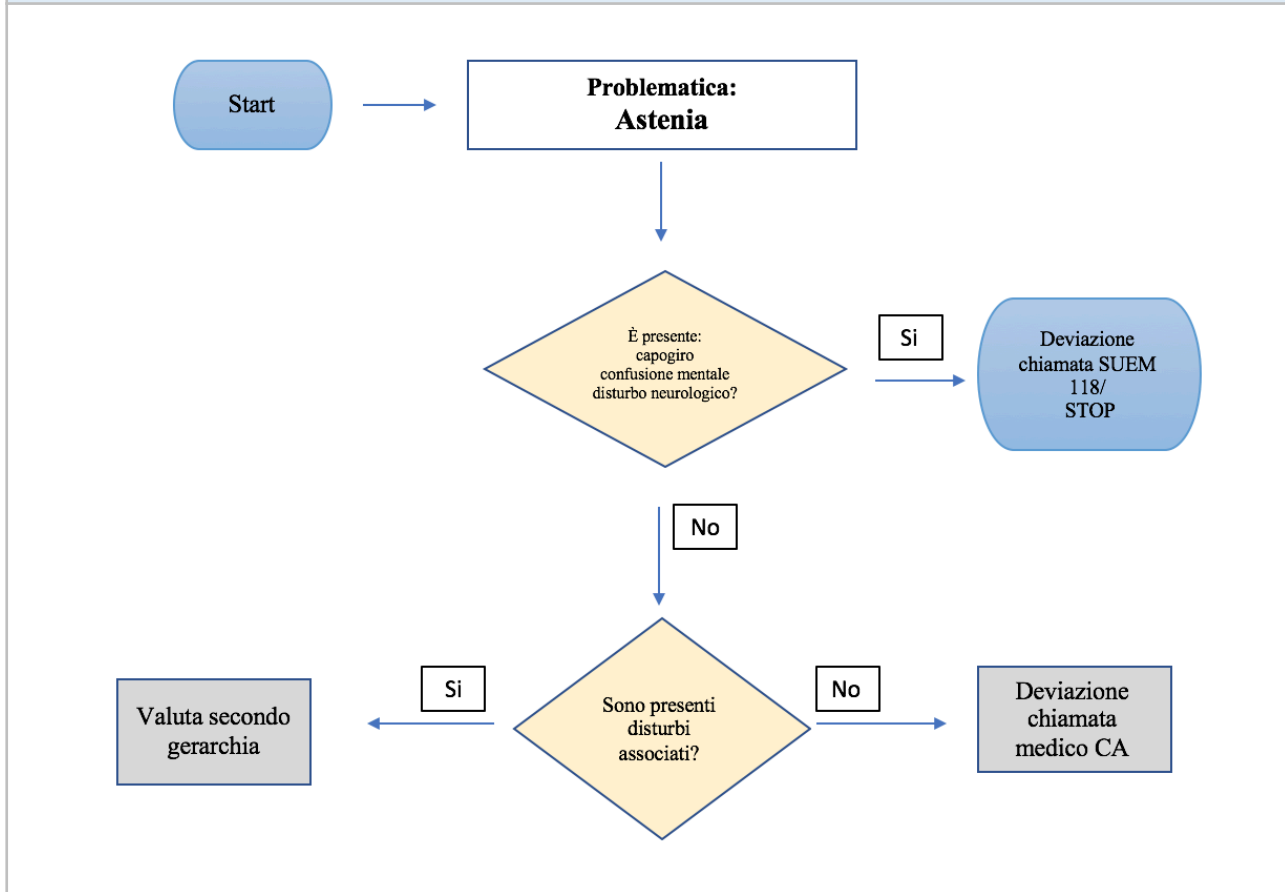
Flowchart



ASTENIA

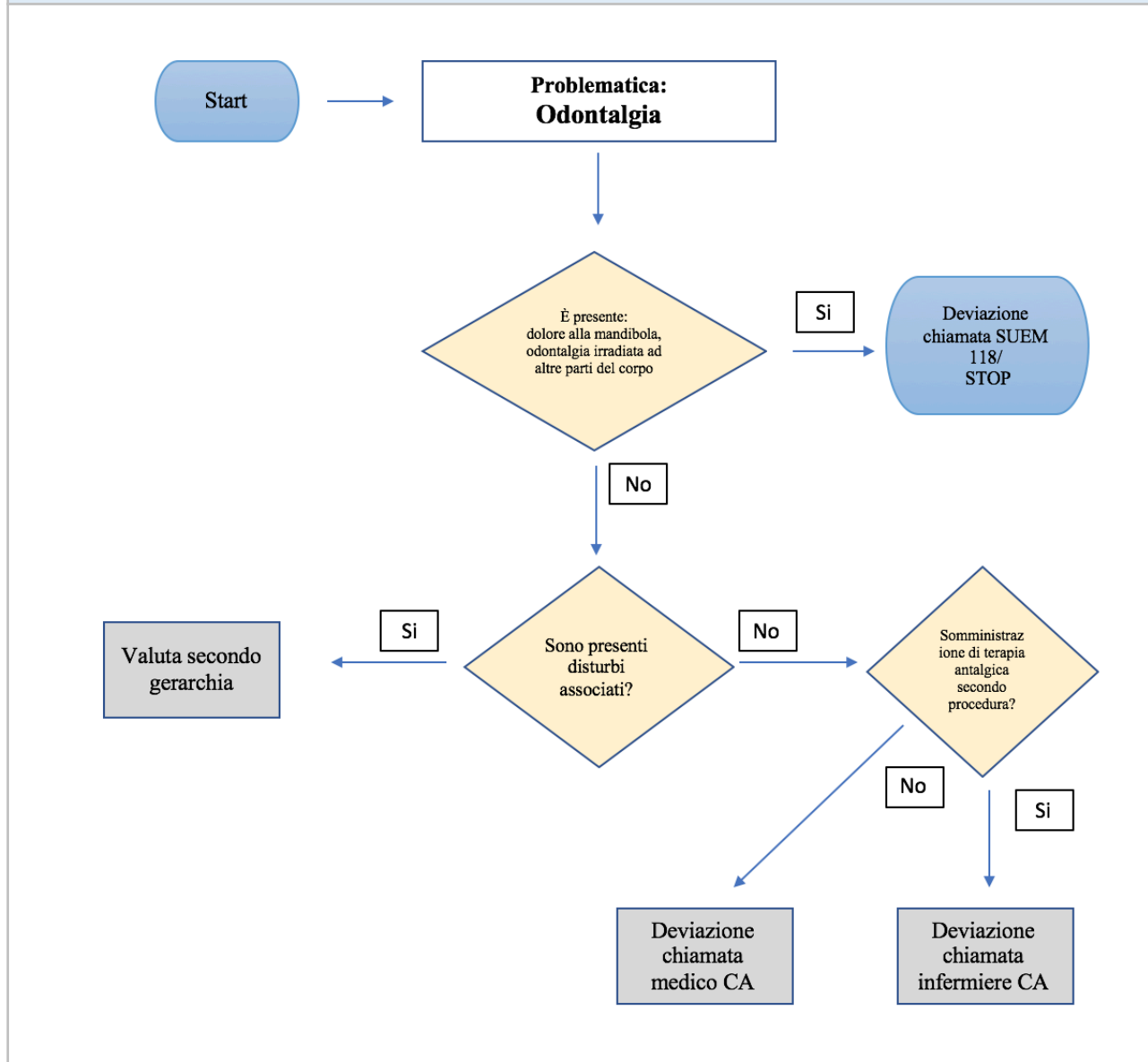
Titolo scheda	Astenia
Definizione	Mancanza di forze
Parole di entrata	Sentirsi fiacco, senso di spossatezza, mancanza di forza, debolezza, debilitato, sfinito, astenico, sentirsi spossato, sentirsi stanco, stufo
Parole alert per 118	Svenimento/perdita di coscienza, cardiopalmo, difficoltà a respirare, confusione mentale, Fa fatica a parlare, fa fatica a deglutire, perdita di forza ad un arto, sorride con metà bocca, metà faccia è immobile, non riesce a muovere gli arti, non alza un braccio, non muove una gamba, trascina una gamba, vede doppio, diplopia, intorpidimento, formicolio, vede male (non vede una parte del campo visivo, vede un pezzo del campo visivo nero, vede una macchia nera), non riesce a chiudere un occhio, cammina male, non riesce a deglutire, non parla bene, parla male, disturbo dell'equilibrio, sbandamento

Flowchart



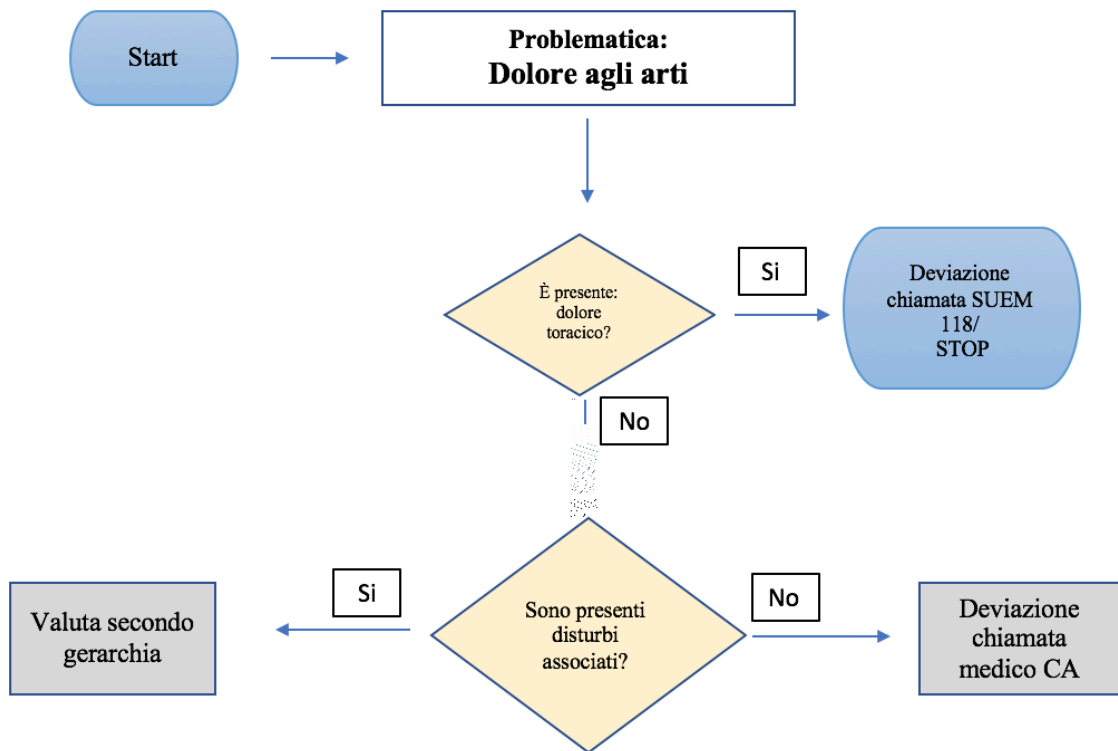
ODONTALGIA

Titolo scheda	Odontalgia
Definizione	Problematiche relative ai denti
Parole di entrata	Odontalgia, mal di denti, dente rotto, distacco di protesi, denti caduti a seguito di traumi isolati
Parole alert per 118	Dolore mandibola, mal di denti irradiato ad altre parti del corpo
Flowchart	



DOLORE AGLI ARTI

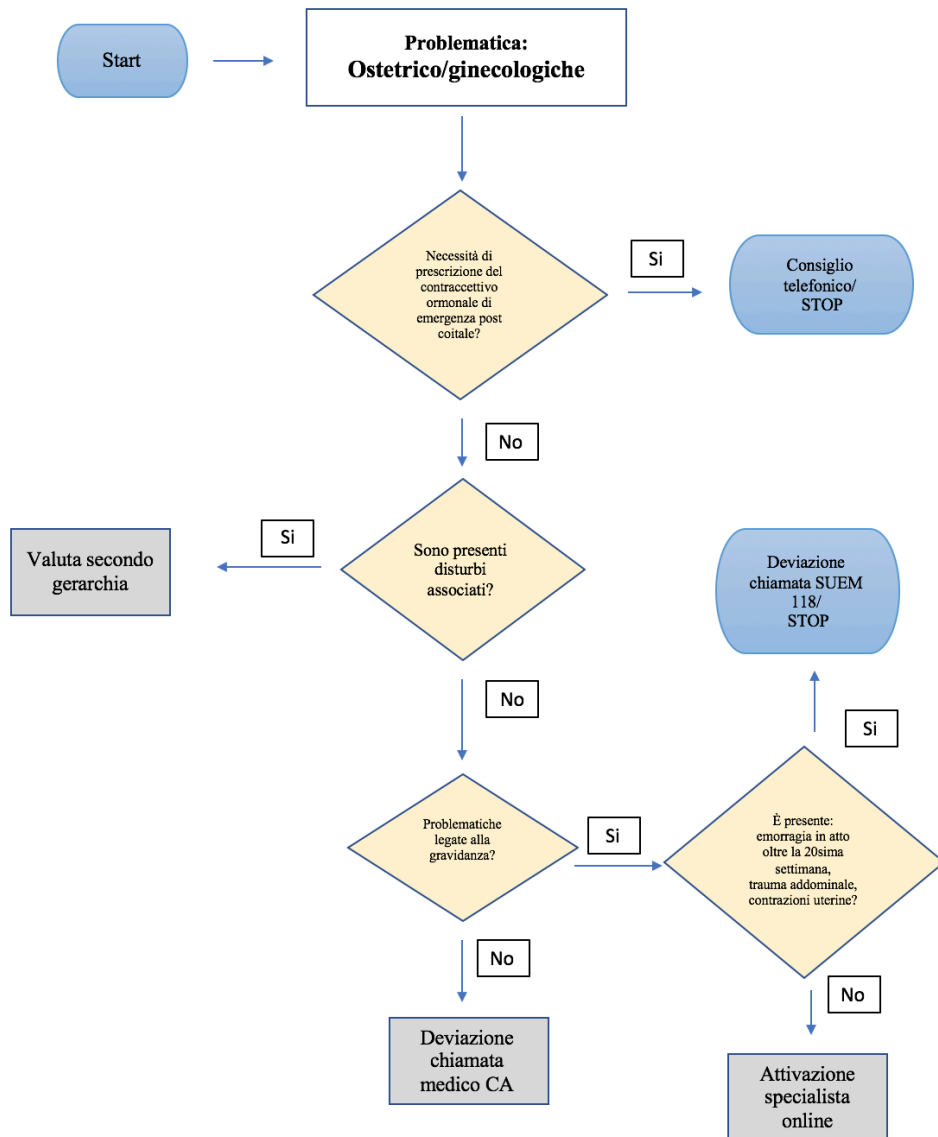
Titolo scheda	Dolore arti
Definizione	Dolore agli arti e alle articolazioni comprese nell'arto di origine non traumatica
Parole di entrata	Male al ginocchio, male alla caviglia, male alle anche, male alla mano, male alle dita della mano, male al polso, male all'avambraccio, male al gomito, gomito da tennista, gonfiore alle articolazioni, male alla spalla, periartrite, male alla palpazione di un arto, male al braccio, male alla coscia, male al ginocchio, ginocchio gonfio, dolore alla gamba, articolazione gonfia e rossa, dolore alla caviglia, male al piede, male alle dita del piede
Parole alert per 118	Perdita di coscienza, dolore toracico, dolore allo stomaco
Flowchart	



OSTETRICO/GINECOLOGICO

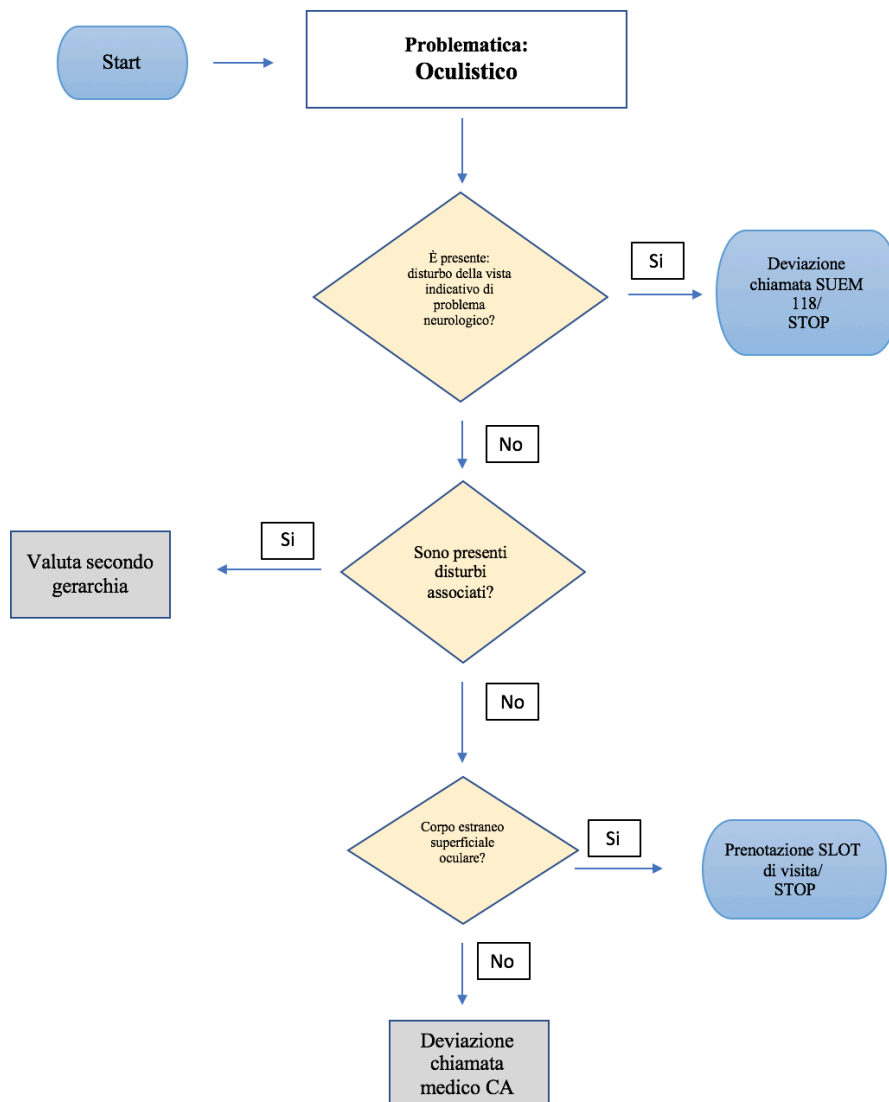
Titolo scheda	Ostetrico/ginecologico
Definizione	Problematiche riguardanti l'apparato genitale femminile
Parole di entrata	Metrorragia, sanguinamento vaginale, peso al basso ventre, dolore vaginale, prurito/bruciore, perdite vaginali, pillola del giorno dopo, anticoncezionale, interruzione volontaria di gravidanza (IVG), rapporto a rischio, gravidanza, contrazioni uterine, allattamento, perdite ematiche in donna gravida, mestruazione abbondante, mestruazione dolorosa, assenza di mestruazioni
Parole alert per 118	Emorragia in atto dopo 20 settimana, parto imminente, contrazioni ravvicinate, trauma addominale in gravida

Flowchart



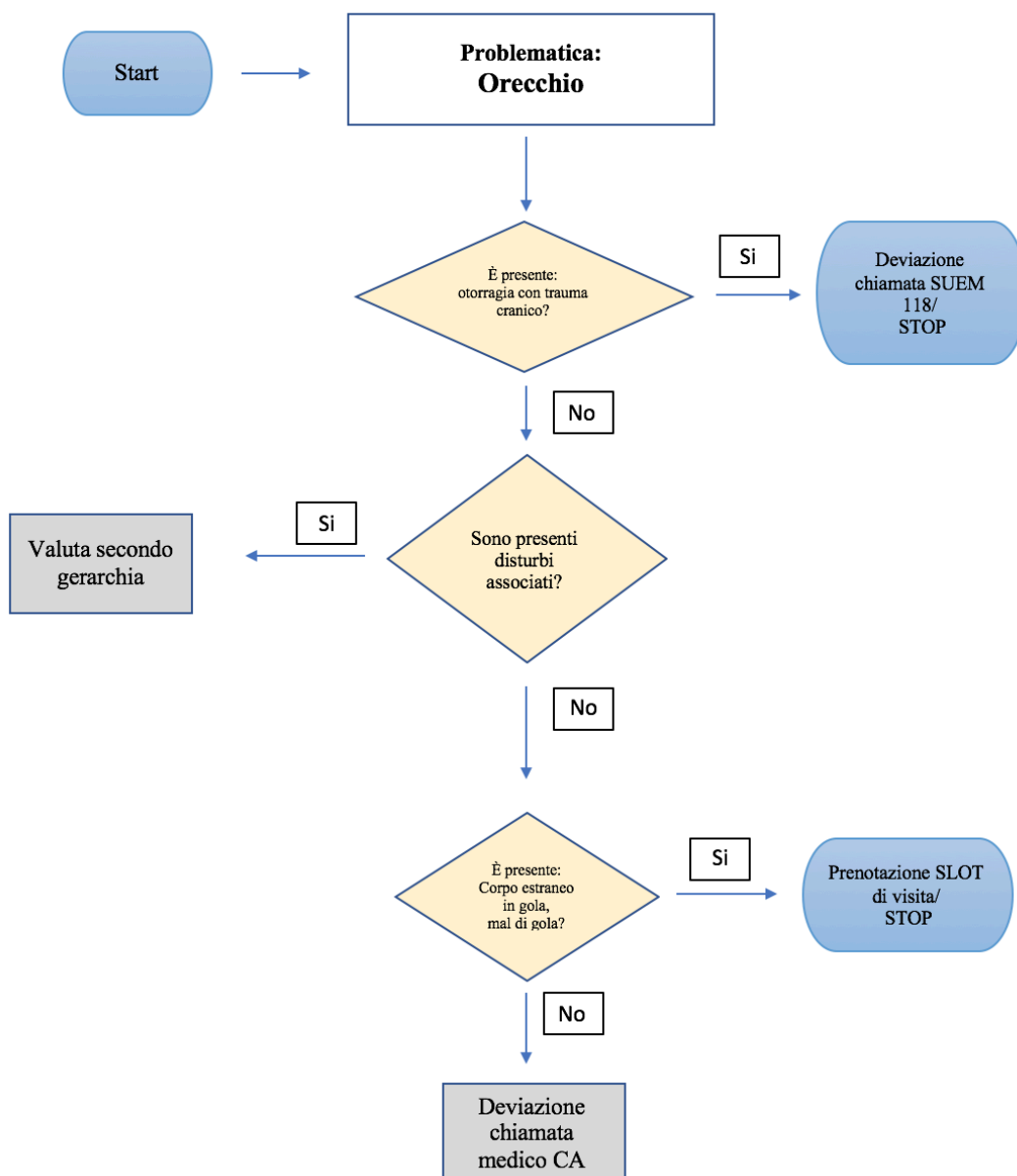
OCULISTICO

Titolo scheda	Oculistico
Definizione	Problemi alla vista di origine non traumatica
Parole di entrata	Vedo male, fatico a vedere, vedo sfuocato, vedo le luci, vedo ragnatela, occhio rosso, mi lacrima l'occhio, occhio dolente, secrezioni all'occhio
Parole alert per 118	Vedo una macchia nera, vedo metà campo visivo nero, rossore periorbitario, occhio tanto rosso e tanto dolente, vedo doppio
Flowchart	



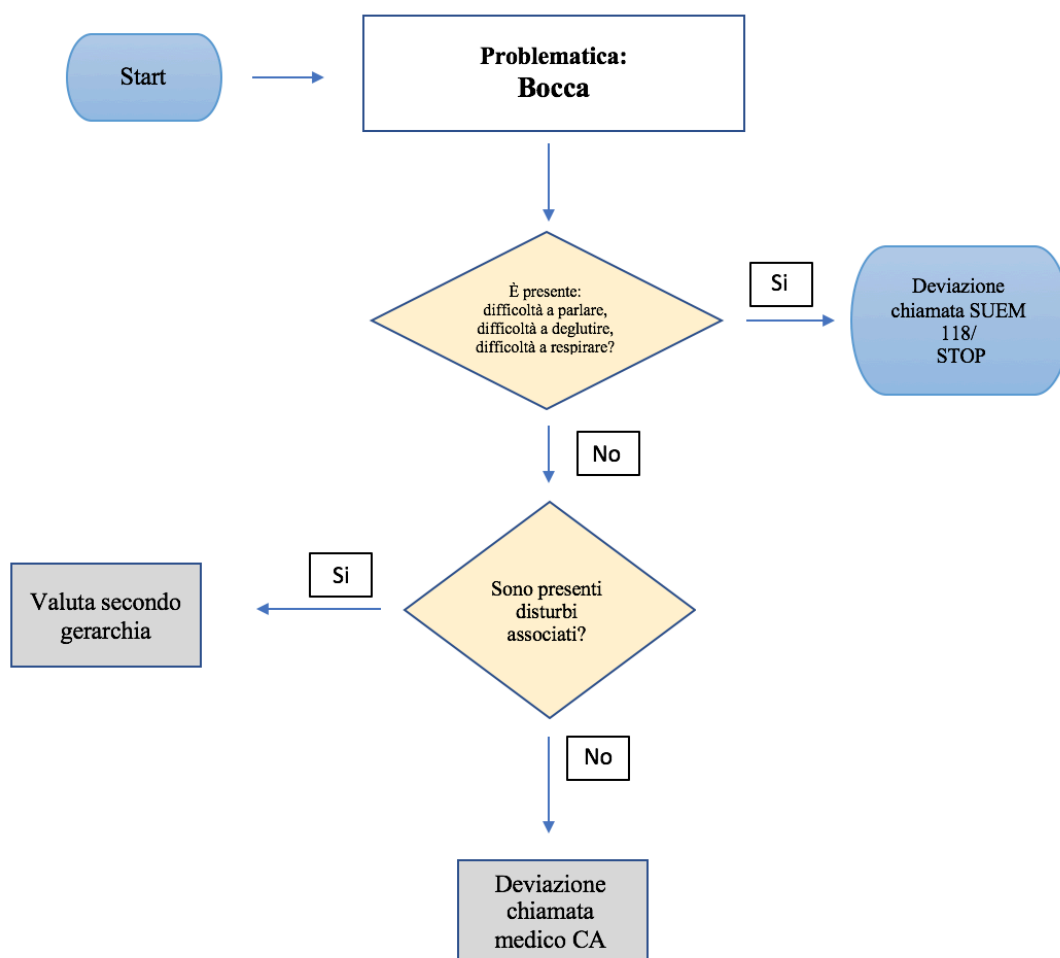
ORECCHIO

Titolo scheda	Orecchio
Definizione	Problematiche relative all'organo orecchio
Parole di entrata	Male alle orecchie, acufeni, sento poco, non sento da un orecchio, sento un fischio continuo, sento ovattato (come sott'acqua), ho le orecchie tappate,
Parole alert per 118	Otorragia con trauma cranico
Flowchart	



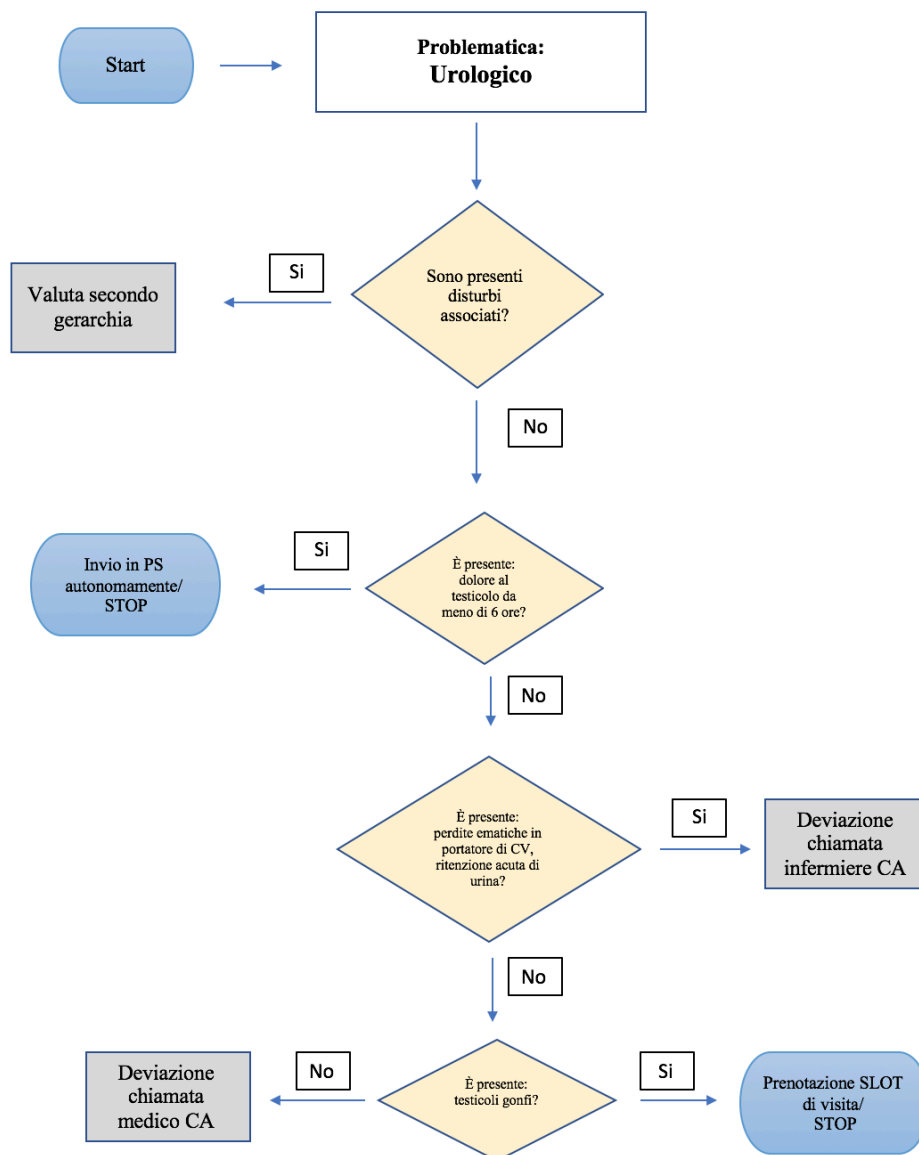
BOCCA

Titolo scheda	Bocca
Definizione	Problematiche relative all'organo bocca
Parole di entrata	Male alla bocca, male alla lingua, male alle gengive, herpes, micosi, afte, mughetto, bocca bianca, lesioni in bocca
Parole alert per 118	Non riesce a parlare, non riesce a deglutire, difficoltà a respirare
Flowchart	



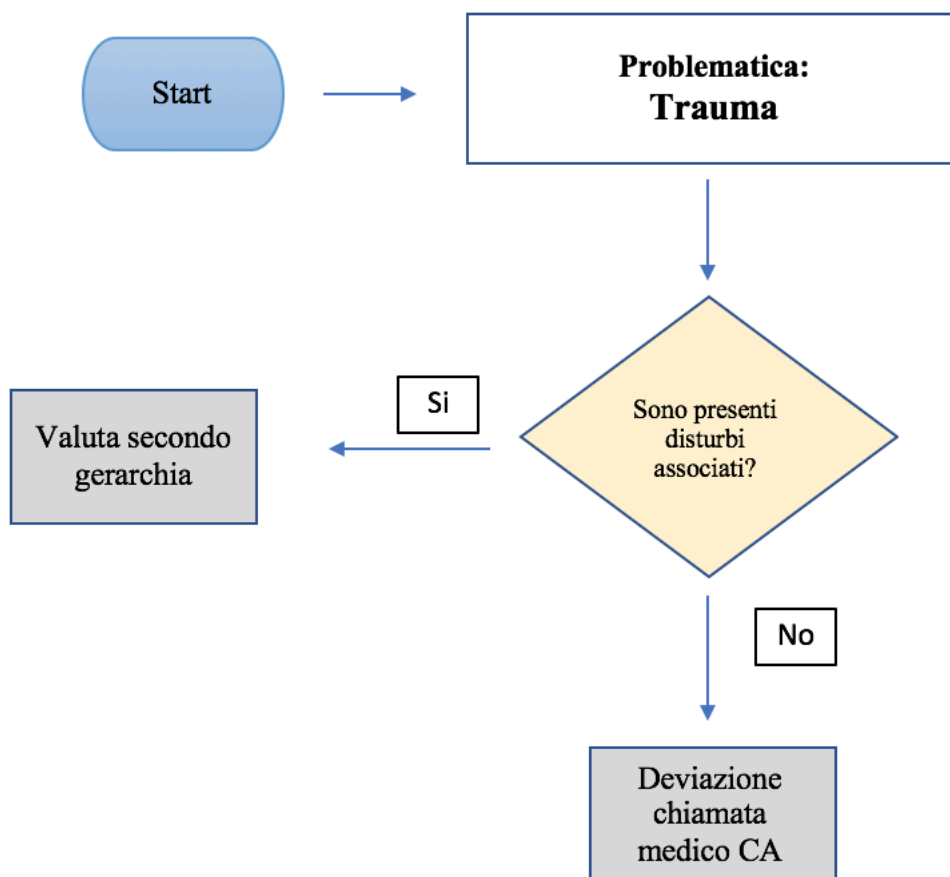
UROLOGICO

Titolo scheda	Urologico
Definizione	Problematiche dell'apparato genitourinario
Parole di entrata	Dolore al testicolo, dolore al pene, non riesce a fare pipì, bruciore minzionale, difficoltà ad urinare, sangue nelle urine, ematuria, secrezioni dal pene,
Parole alert per 118	/
Percorso della scheda	



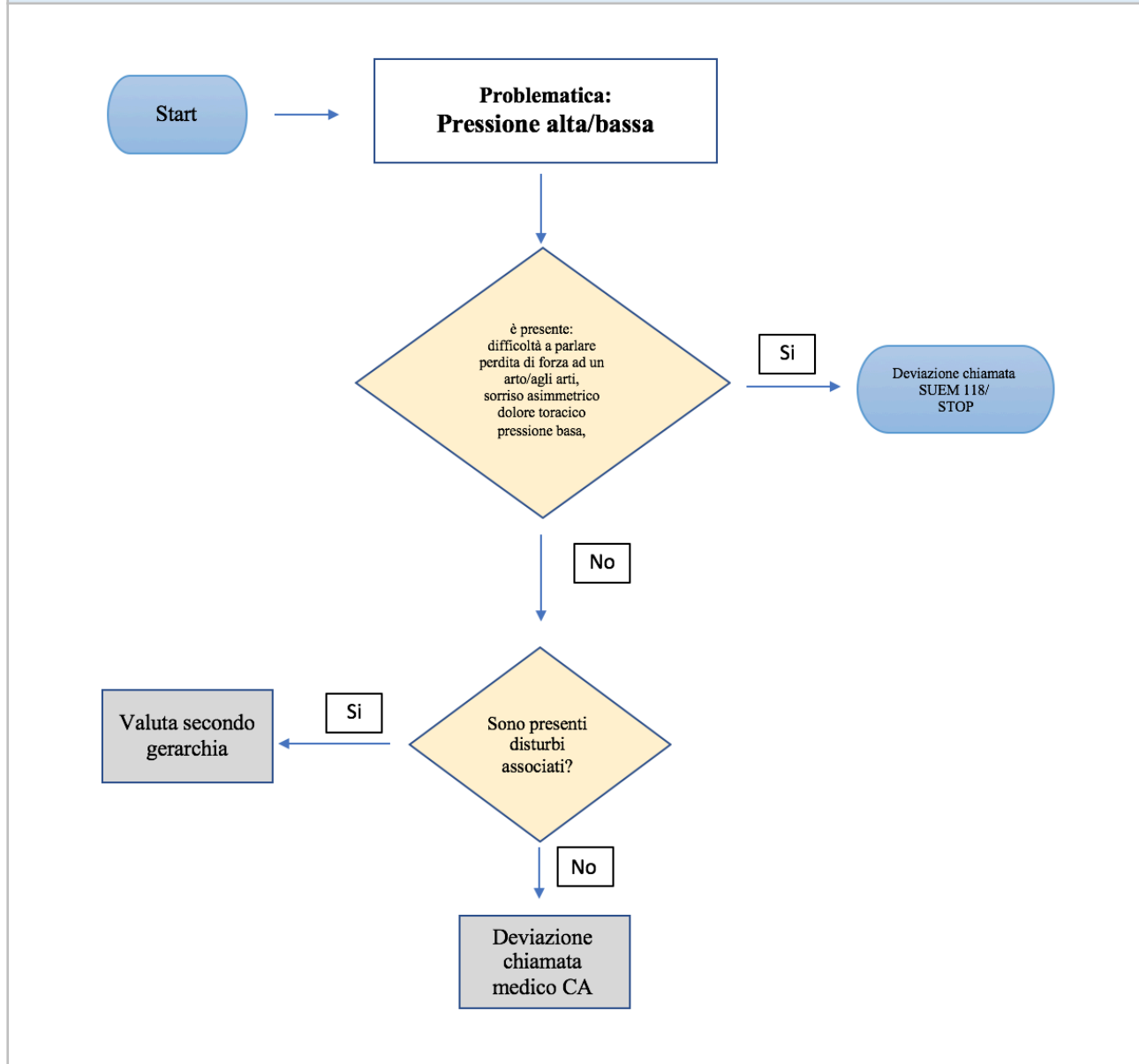
TRAUMA

Titolo scheda	Trauma
Definizione	Traumatismi di qualsiasi natura e in qualsiasi sede
Parole di entrata	Ho preso una botta/storta/ in qualche parte del corpo, scivolato, inciampato, sbattuto, ferite, tagliato, incidente, tamponato, colpo di frusta, stiramento, distrazione cervicale,
Parole alert per 118	Sincope, difficoltà respiratoria
Flowchart	



PRESSIONE ALTA/BASSA

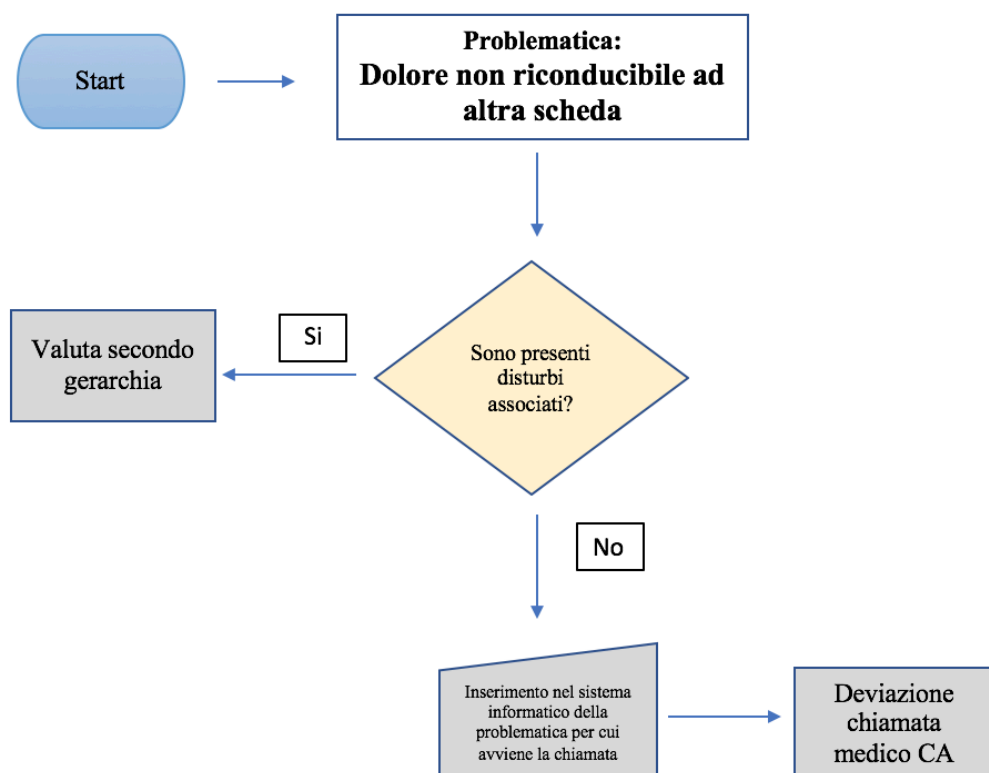
Titolo scheda	Pressione alta/bassa
Definizione	Dichiarazione di pressione alta o bassa
Parole di entrata	Pressione alta, ipertensione, pressione, pressione bassa, ipotensione
Parole alert per 118	Fatica a parlare, perdita di forza ad un arto, non riesce a muovere gli arti, sorriso asimmetrico, cardiopalmo, episodio di perdita di coscienza, dolore toracico, pressione bassa, ipotensione
Flowchart	



DOLORE NON RICONDUCEBILE AD ALTRA SCHEDA

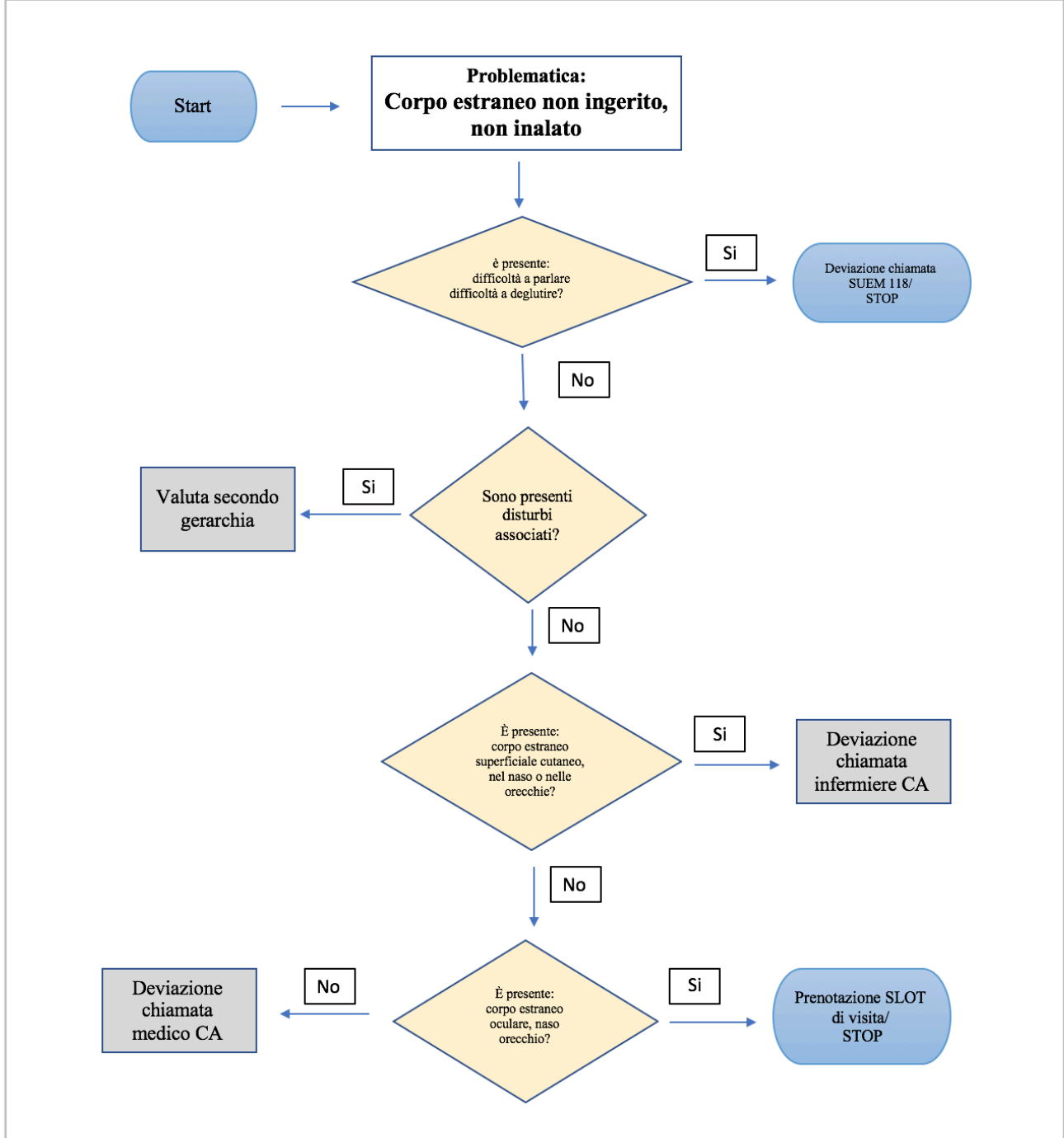
Titolo scheda	Dolore non riconducibile ad altra scheda specifica
Definizione	Dolore di origine non traumatica in sedi del corpo non identificate con altre schede
Parole di entrata	Dolore, male, malessere generalizzato, ho male dappertutto
Parole alert per 118	/

Flowchart



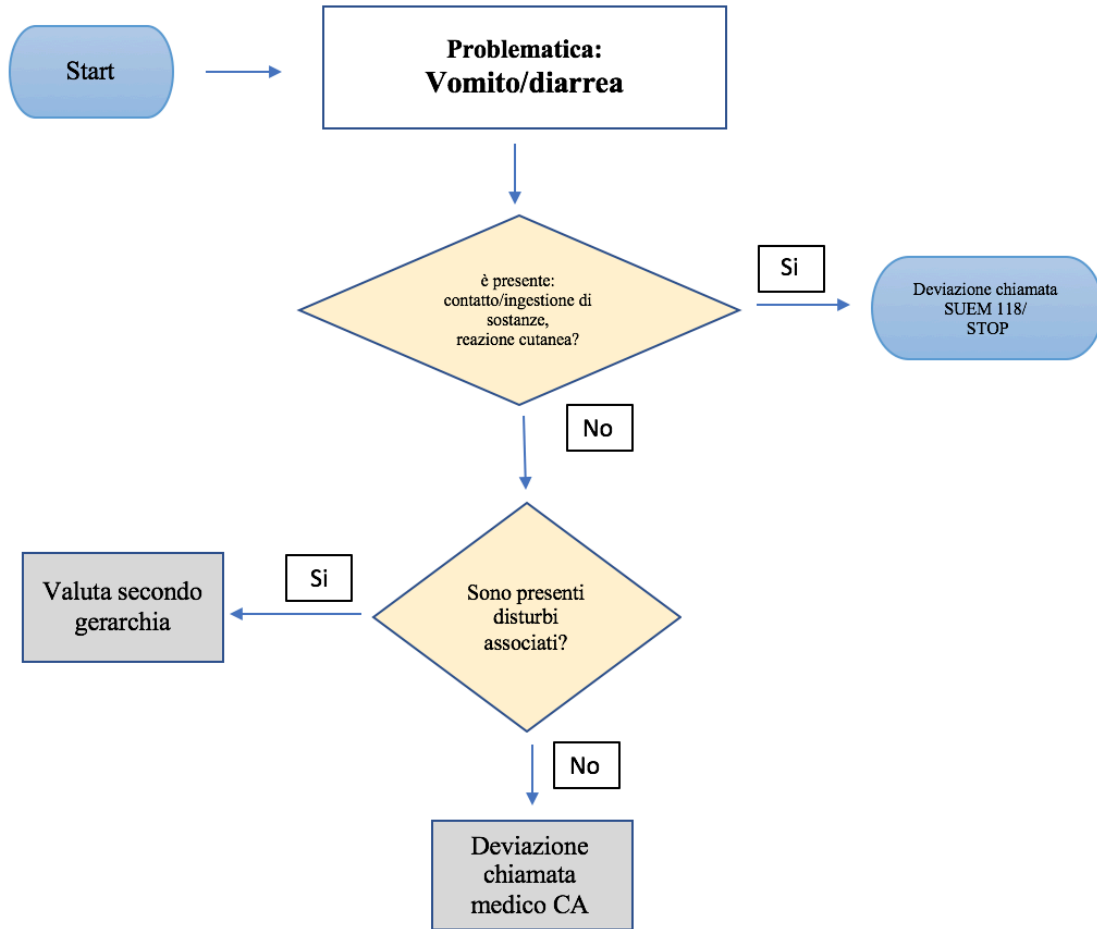
CORPO ESTRANEO NON INGERITO, NON INALATO

Titolo scheda	Corpo estraneo non ingerito, non inalato
Definizione	Presenza di oggetti (anche piccoli) estraneo al corpo in qualsiasi parte del corpo non ingerito e non inalato [intossicazioni]
Parole di entrata	Spina, scheggia, corpo estraneo,
Parole alert per 118	Fa fatica a deglutire, fa fatica a respirare
Percorso della scheda	



VOMITO/DIARREA

Titolo scheda	Vomito/diarrea
Definizione	Vomito o diarrea
Parole di entrata	Vomito, diarrea, scarica feci liquide, dissenteria, rimettere, rigurgito, rigettare, mi è venuto su,
Parole alert per 118	Reazione cutanea, contatto/ingestione di sostanze
Flowchart	



PROBLEMATICHE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

Titolo scheda	Problematica non altrimenti classificabile in altra scheda [ATTENZIONE!!! SPECIFICARE, IN UN CAMPO LIBERO, IL MOTIVO DELLA CHIAMATA]
Definizione	Tutte le problematiche non comprese nelle schede precedenti
Parole di entrata	/
Parole alert per 118	/
Flowchart	
<pre> graph TD Start([Start]) --> Problematica[Problematica: Problematiche non altrimenti classificabili in altre schede] Problematica --> Inserimento[/Inserimento nel sistema informatico della problematica per cui avviene la chiamata/] Inserimento --> Deviazione[Deviazione chiamata medico CA] </pre> The flowchart illustrates the process for handling problems not otherwise classifiable. It begins with a 'Start' terminal, leading to a process box labeled 'Problematica: Problematiche non altrimenti classificabili in altre schede'. This leads to a data input box 'Inserimento nel sistema informatico della problematica per cui avviene la chiamata', which finally leads to an output box 'Deviazione chiamata medico CA'.	

PROCEDURE

Sono state individuate delle procedure specifiche per la figura del medico e per la figura dell'infermiere di centrale operativa.

Professionista	Procedure
Medico	- Certificazioni malattia - Prescrizione/informazione farmaci o esami strumentali urgenti - Constatazione decesso - ASO - Informazioni/visione esami ematochimici
Infermiere	- Somministrazione terapia già prescritta - Gestione di catetere vascolare - Gestione di catetere vescicale - Gestione di stomie - Gestione di tracheo - Gestione di sondini naso gastrici - Gestione di nutrizione parenterale - Gestione di PEG - Medicazioni - Rimozione punti - Suture semplici? - Vaccinazioni antitetaniche - Gestione del soggetto con stipsi senza dolore addominale - Rimozione zecche

PAROLE ALERT PER DEVIAZIONE CHIAMATA A SUEM 118

Di seguito vengono riportate tutte le parole comprese nelle diverse schede che devono allertare l'operatore e per le quali deve essere attivato il servizio SUEM 118.

Parole alert	Sincope Dispnea Cardiopalmò Dolore Toracico Disturbo Neurologico <24h Emorragia in Atto Dopo 20 Settimane Parto Imminente Contrazioni Ravvicinate Confusione Mentale Fa Fatica A Parlare Fa Fatica A Deglutire Perdita Di Forza Ad Un Arto, Non Riesce A Muovere Gli Arti Sorriso Asimmetrico Disturbo Psicico Da Più Di 24 H Pz In Grave Agitazione Psicomotoria/Aggressivo Vuole Uccidersi Dolore Mandibola O Odontalgia Irradiate Ad Altre Parti Del Corpo Aneurisma Aneurisma Aorta Stomaco Dolore Sopra Ombelico Sudato Ferita Vomito Con Sangue Assunzione Sostanze Gonfiore Arrossamento Dal Collo In Su Vede Una Macchia Nera Vede Doppio Alterazione Del Campo Visivo Con O Senza Trauma Otorragia Con Trauma Cranico Perdita Di Coscienza Vertigini Vomita Sangue Tossisce Sangue Scarica Sangue
---------------------	---

QUESITI APERTI:

- Questo numero come si interfaccerà con le attività assistenziali già in essere?
- Pediatra è uno specialista online?

PROPOSTE

- Attivazione di un pool di ambulanze deputate al trasporto in PS dei soggetti impossibilitati a recarsi in ospedale in autonomia ma che presentano problematiche che non richiedono l'attivazione del 118
- Consulente pediatrico per la costruzione di alcune schede specifiche

Tutte le chiamate saranno notificate ai MMG e PLS curanti.

Per ogni AULSS/distretto dovranno essere disponibili e consultabili online sul sito aziendale gli orari di accesso alle strutture ambulatoriali per accessi U specialistici preferibilmente con impegnativa CA/curante o in alternativa in fast-track. Di conseguenza questa potrebbe diventare una soluzione per vari problemi